

LES ENDOMETRIOSIS ES

S.JAYI
Service de GO2
jayisofia@gmail.com

INTRODUCTION

- Maladie inflammatoire chronique oestrogéno-dépendante
- Présence du tissu endométrial (épithélium +- stroma) en dehors de la cavité utérine
- Surtout la femme en âge de procréer
- Au moins 190 millions femmes+ adolescentes dans le monde
- Symptômes : Douleur et ou infertilité et ou saignement utérin anormal
- Retentissement sur qualité de vie : impact psycho-social, professionnel ,conjugale , familiale
- Retard diagnostic : 7 ans
- Médecin généraliste : 1 er interlocuteur +++++++

PLAN

- I. INTRODUCTION
- II. CLASSIFICATION
- III. EPIDEMIOLOGIE
- IV. PHYSIOPATHOLOGIE
- V. anatomopathologie
- VI. CLINIQUE
- VII. EXAMENS PARACINIQUES
- VIII. DEMARCHE DIAGNOSTIQUE
- IX. STADIFICATION
- X. PPRISE EN CHARGE
 - Intervenants
 - Buts de la PEC
 - Moyens
 - Stratégie thérapeutique
- XI. SURVEILLANCE
- XII. PRESERVATION FERTILITE
- XIII. CONCLUSION

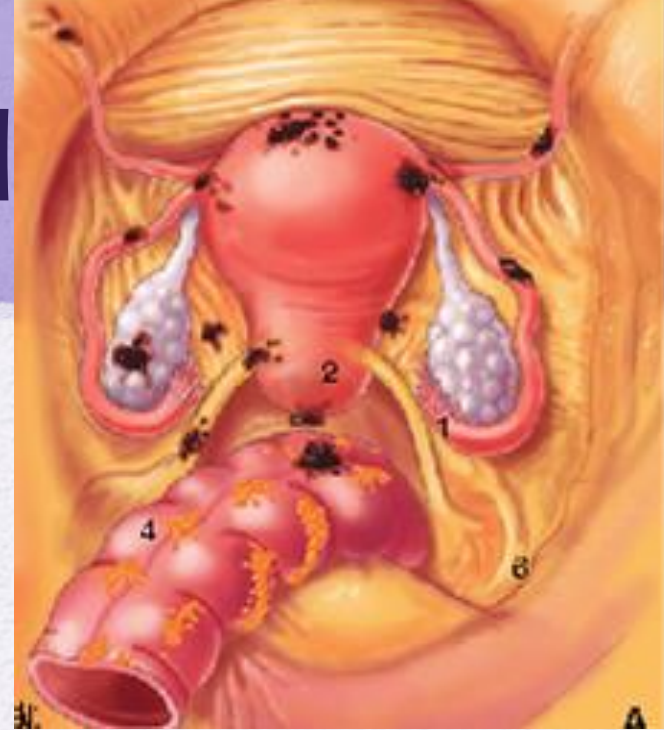
OBJECTIFS

- Savoir Expliquer à la patiente ce qu'est une endométriose et les conséquences de cette affection
- Connaître l'épidémiologie
- Connaître la clinique
- Connaître les signes radiologiques échographiques
- Connaître les bases du traitement.
- Connaître les modalités de surveillances

CLASSIFICATION

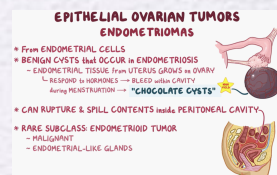
- L'endométriose interne : adénomyose
- Endométriose externe : en dehors de l'utérus
- Association des 2 fréquente mais pas obligatoire

CLASSIFICATION



Endométriose externe : en dehors de l'utérus

- l'endométriose superficielle : implants superficiels **du péritoine**
- l'endométriose profonde **sous-péritonéale** (EPSP)
 - = >5 mm du péritoine/ atteinte musculuse de l'organe cible
- l'endométriose ovarienne : endométriome
- **Autres** L'endométriose pariétale (sur cicatrice de chirurgie),ombilic,
Poumon



L'endométriiose interne = adénomyose :

l'invagination du tissu endométrial dans le myomètre:

 l'adénomyose diffuse/ focale

- diffuse: fréquente, même chez les femmes jeunes
- focale = adénomyome



externe / interne :

- adénomyose externe du myomètre externe (fréquente si endométriiose externe infiltrante profonde++)
- Adénomyose interne

Peritoneum

Fallopian tube

Ovary

OMA

Rectum

Uterus

Bladder

Pelvic bone

M

JZ

Diffuse adenomyosis FAOM DIE SUP

FAOM: Adénomyose externe

DIE: endometriose externe profonde sous péritonéale

Sup: endpmétrieose externe superficielle

EPIDEMIOLOGIE

- 15 % des femmes en période d'activité génitale OR : sous estimée!
- 40%des femmes endométriosiques : sont hypofertiles
- 50 % des femmes infertiles sont endométriosiques
- 2-10% population générale
- 1/3 algies pelviennes chroniques
- diagnostic en cas de DLR : 7 ans , en cas d'infertilité: 3 ans
- Comparable voire sup diabète:
- Programme nationale de lutte contre l'endométriose (certains pays)
- Au maroc: ENDOMAROC

EPIDEMIOLOGIE

Facteurs de risque

- exposition plus importante aux menstruations +++:

malformation obstructive, règles précoces, cycles courts, règles abondantes, nullparité

- Héritabilité 50% des cas (multigénique)
- Perturbateurs endocriniens
- pathologie inflammatoires et immunitaire

PHYSIOPATHOLOGIE

Endométriose= maladie des théories

- Théorie métaplasique
- Théorie d'induction
- Théorie immunitaire
- Métastases lymphatiques , vx
- Théorie mécanique
- reflux menstruel par les trompes.

➤ Théorie la plus séduisante: contraintes mécaniques → adénomyose
↓
Reflux menstruel → endométriose externe

Adénomyose

contraintes mécaniques → adénomyose

- pression sur couche basale de l'endomètre et le myomètre interne + hyper- et dyscontractilité du myomètre externe en phase menstruelle
- l'hyperpéristaltisme ascendant de l'utérus en fin de phase folliculaire

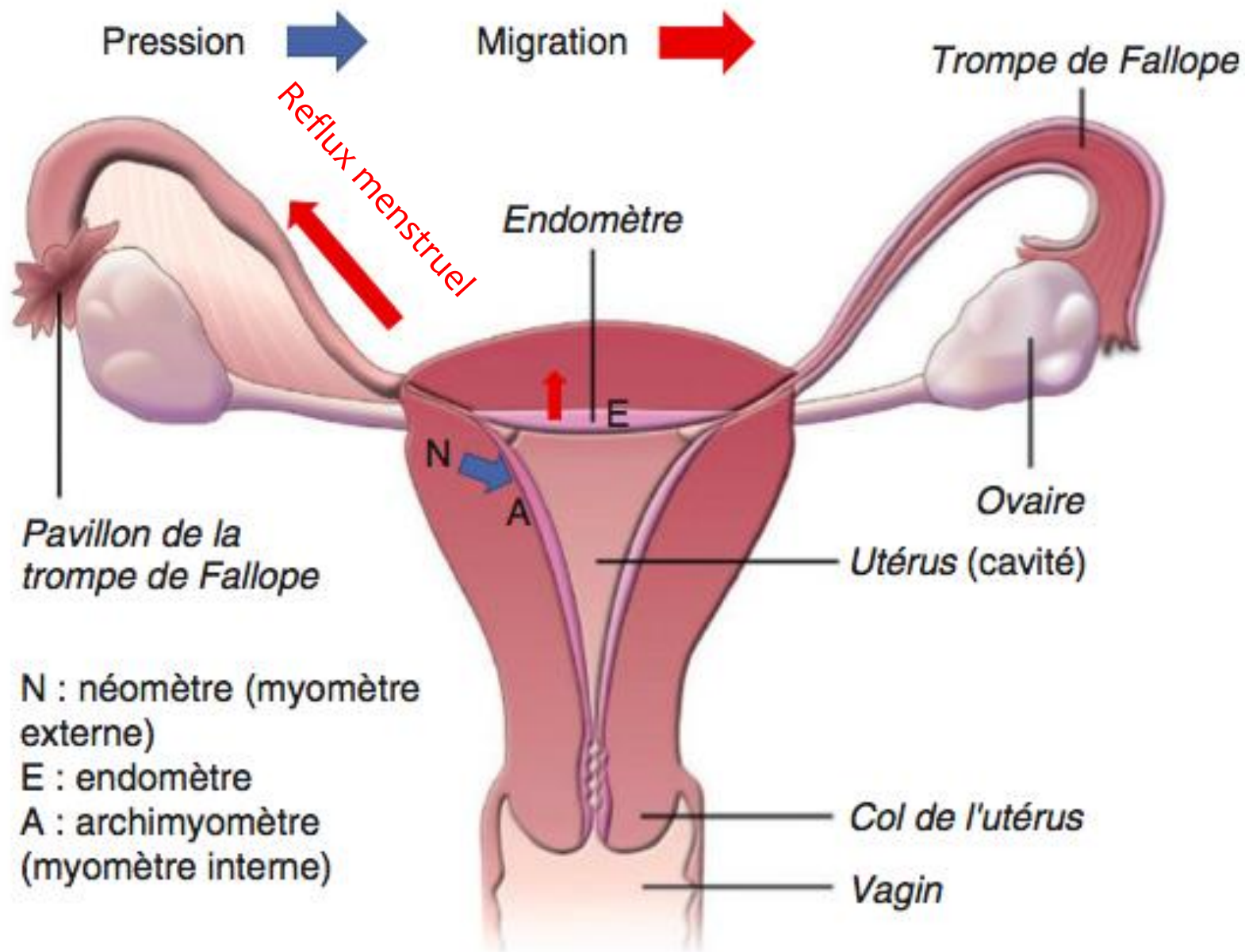
→ un autotraumatisme répété

↓
irruption des cellules endométriale dans l'archimyomètre

(physiologique après 40 ans Or possible dès l'adolescence si :

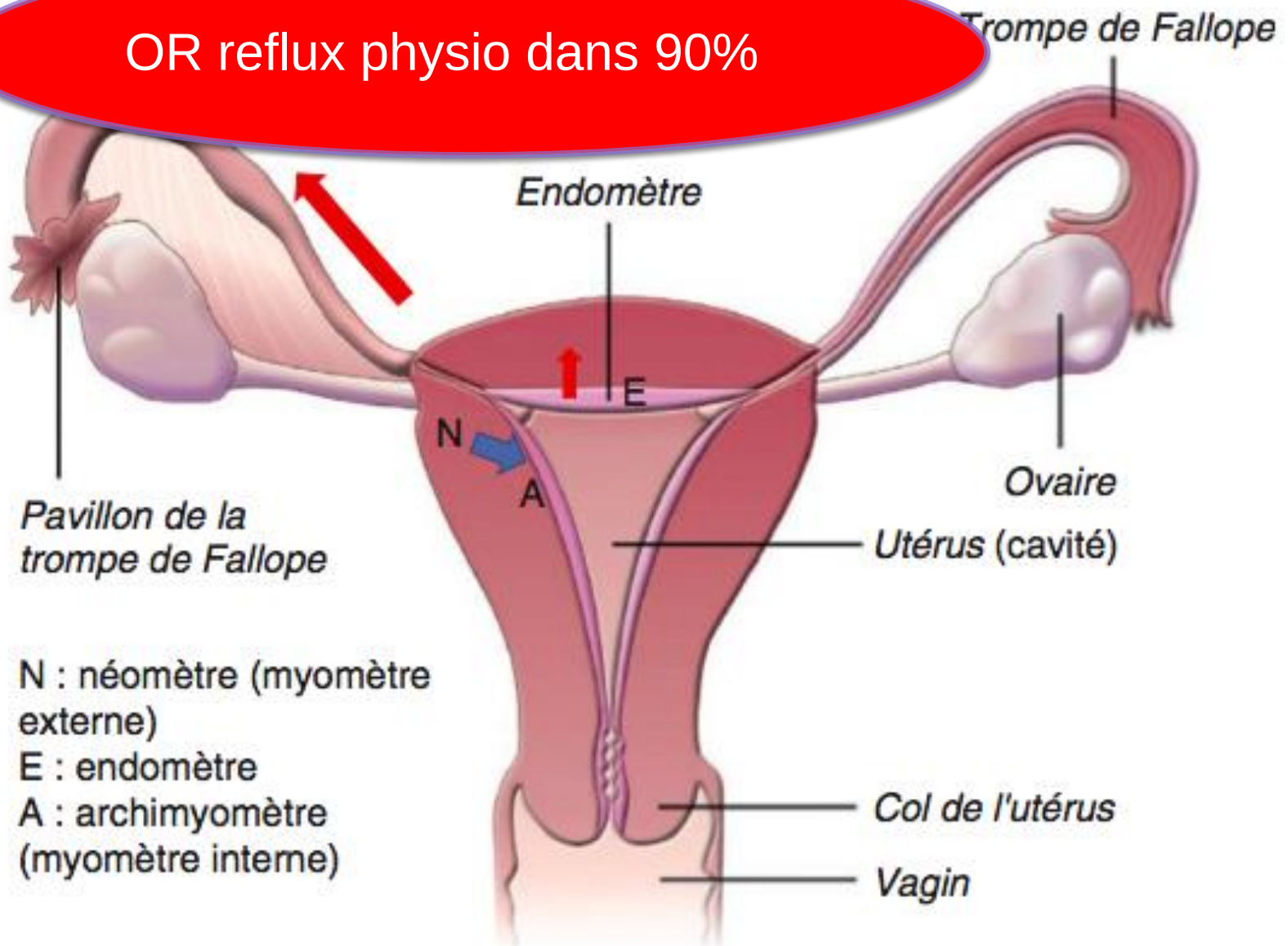
raisons hormonales complexes surtout: hyperœstrogénie, notamment

locale d'origine endométriale (endomètre eutopique pathologique)



un autotraumatisme répété

OR reflux physio dans 90%



Endométriose externe

reflux menstruel = primum movens

Génétique

Epi génétique

Immunité

Nutrition

Facteurs
hormonaux

- hyperONE
- Résistance à la progestéron

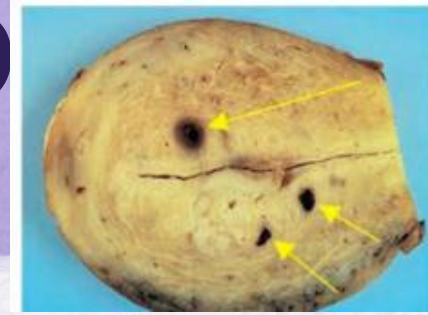
Grefe endométriale extra-utérine

Devenir de l'endomètre ectopique

- L'endomètre normalement ;croît sous l'influence des œstrogènes, puis se décidualise progressivement en deuxième partie de cycle. Or : **réaction de ces îlots glandulaires est imparfaite** (leur vascularisation insuffi- sante ou de leur isolement au sein d'une réaction inflammatoire).
- **l'aggravation des lésions est habituelle** mais non obligatoire.
- **parfois régression** des lésions. Par nécrose du pédicule vasculaire remplacé par une **cicatrice fibreuse**. Cette dernière **peut évoluer pour son propre compte** et enserrer l'uretère ou le hile ovarien.
- Deux événements vont conduire à **la guérison spontanée**
 - la grossesse
 - la ménopause.



ANATOMOPATHOLO



adénomyose

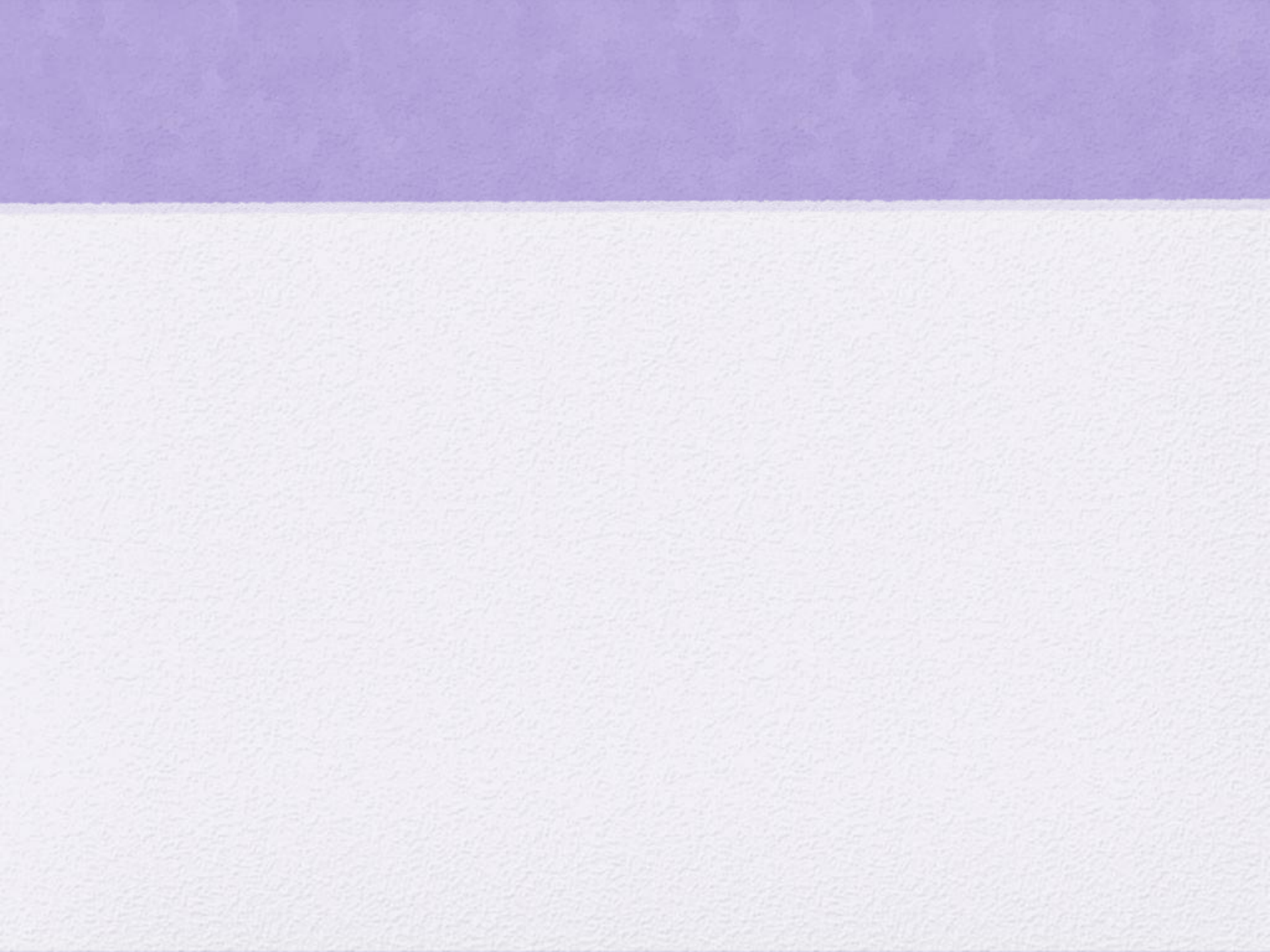
- Petites glandes endométriales kystiques entourées d'une couronne de stroma, contenu séro-hématique
- Hyertrophie des fibres musculaires lisses du myomètre secondaire aux phénomènes inflammatoires cataméniaux

Endométriose externe

- l'endométriose superficielle implants superficiels du péritoine
- l'endométriose ovarienne
- l'endométriose profonde= sous-péritonéale (EPSP)
situé >5 mm du péritoine ou atteinte musculuse de l'organe cible

PLAN

- I. INTRODUCTION
- II. CLASSIFICATION
- III. EPIDEMIOLOGIE
- IV. PHYSIOPATHOLOGIE
- V. anatomopathologie
- VI. CLINIQUE
- VII. EXAMENS PARACINIQUES
- VIII. STADIFICATION
- IX. PPRISE EN CHARGE
 - Intervenants
 - Buts de la PEC
 - Moyens
 - Stratégie thérapeutique
- I. SURVEILLANCE
- II. PRESERVATION FERTILITE
- III. CONCLUSION



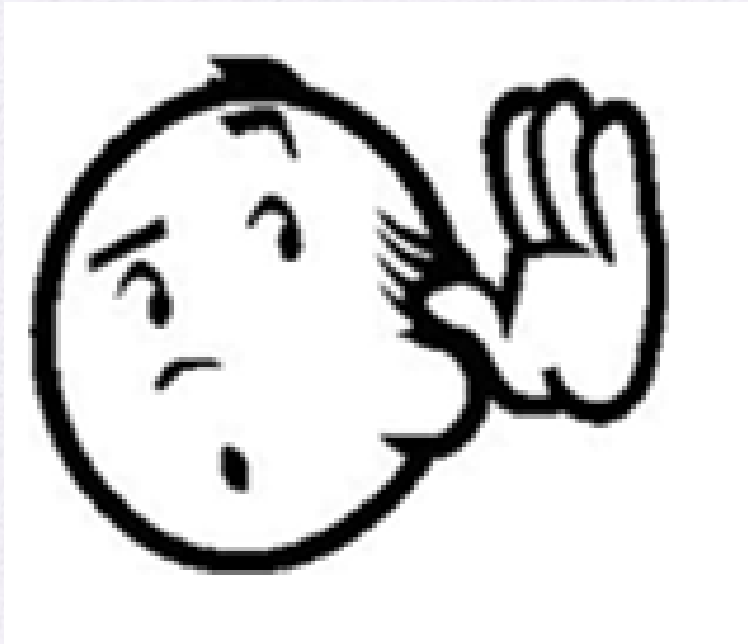
Comment diagnostiquer?

pathologies courantes ↔ grand retard diagnostique

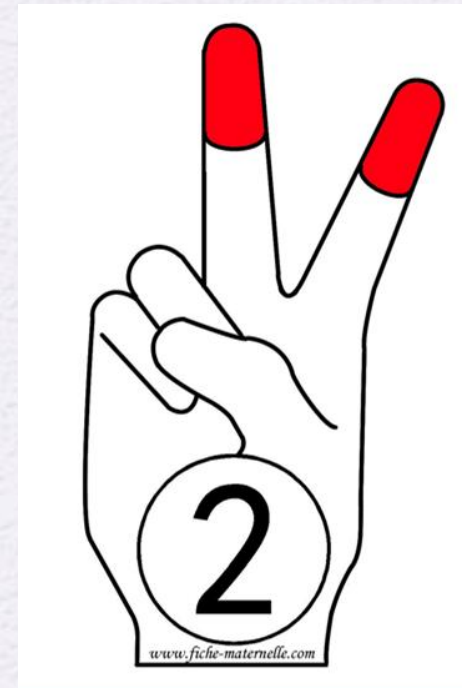


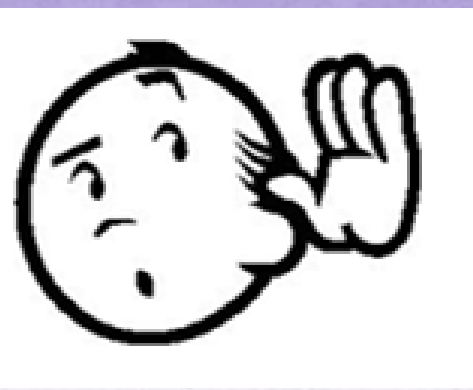
CLINIQUE

INTERROGATOIRE



EXAMEN CLINIQUE





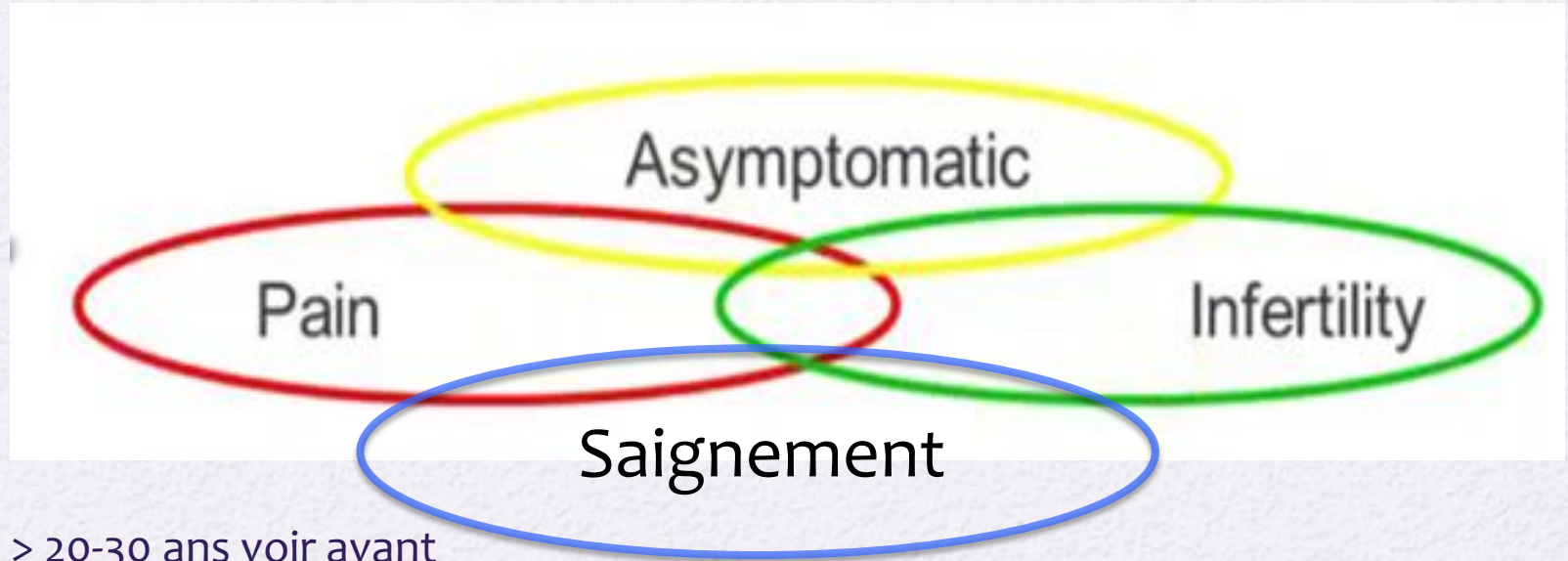
INTERROGATOIRE

Xxx localisations



Polymorphisme sémiologique

QE!! →

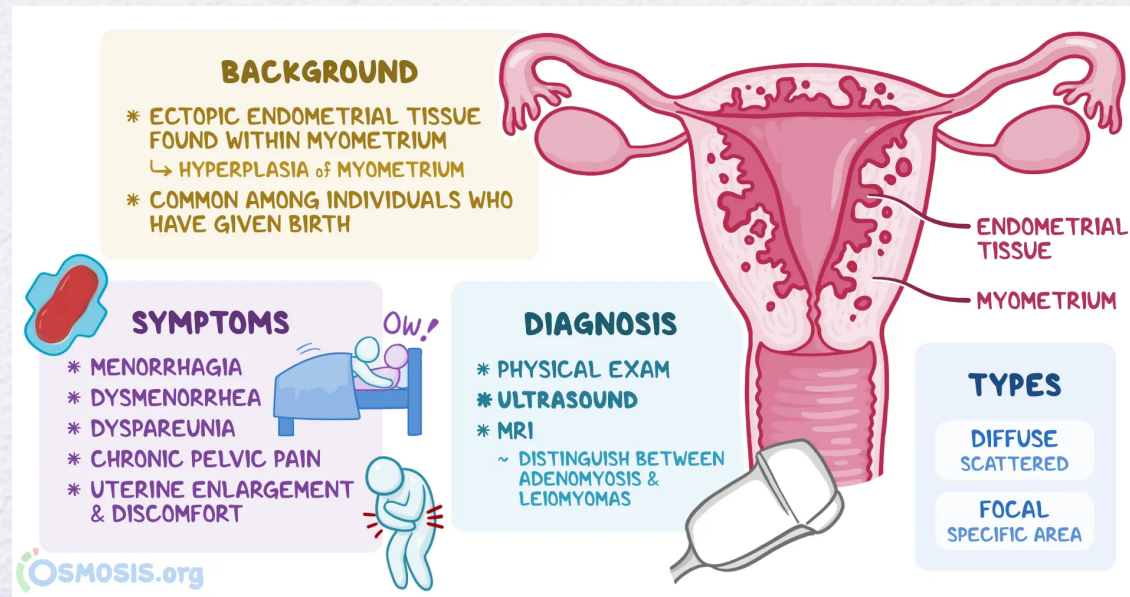


- Age: > 20-30 ans voir avant
- autres signes évocateurs rares
- Comorbidités

Saignement

Adénomyose

- **Les diverticules augmente de volume** , dissociant les fibres musculaires, gênant leur possibilité de rétraction et entraînant des **ménorragies**



douleur

Enzymes

Sécrétion de PG et leur récepteurs

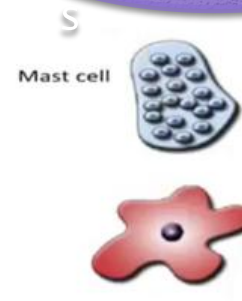
Douleur

Central sensitization

S*chronique du SNC

Pg : stimule neuro-angiogénese périphérique

Cellules
immunitaire



Infertilité

Inflammation

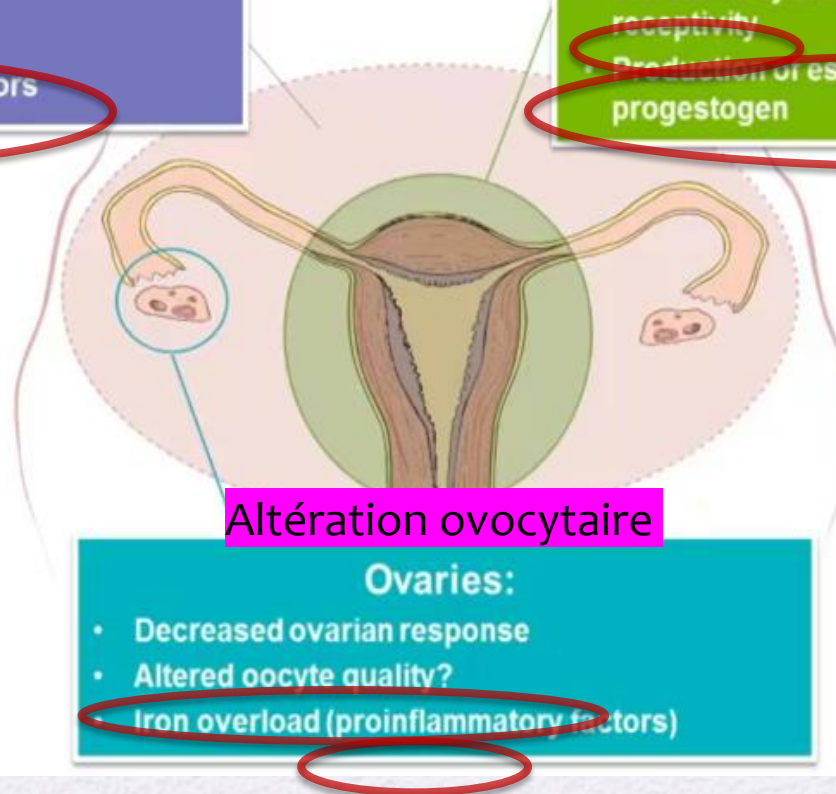
Pelvic cavity:

- Proliferation of macrophages
- Phagocytic dysfunction
- Release of proinflammatory factors

Réceptivité endométriale

Uterus:

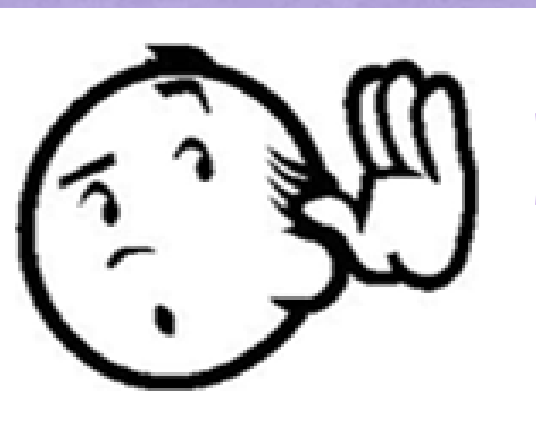
- Increased synthesis of prostaglandin & altered receptivity
- Production of estrogens *in situ* and resistance to progesterone



Ovaries:

- Decreased ovarian response
- Altered oocyte quality?
- Iron overload (proinflammatory factors)

+ Fréquence des rapports sexuels

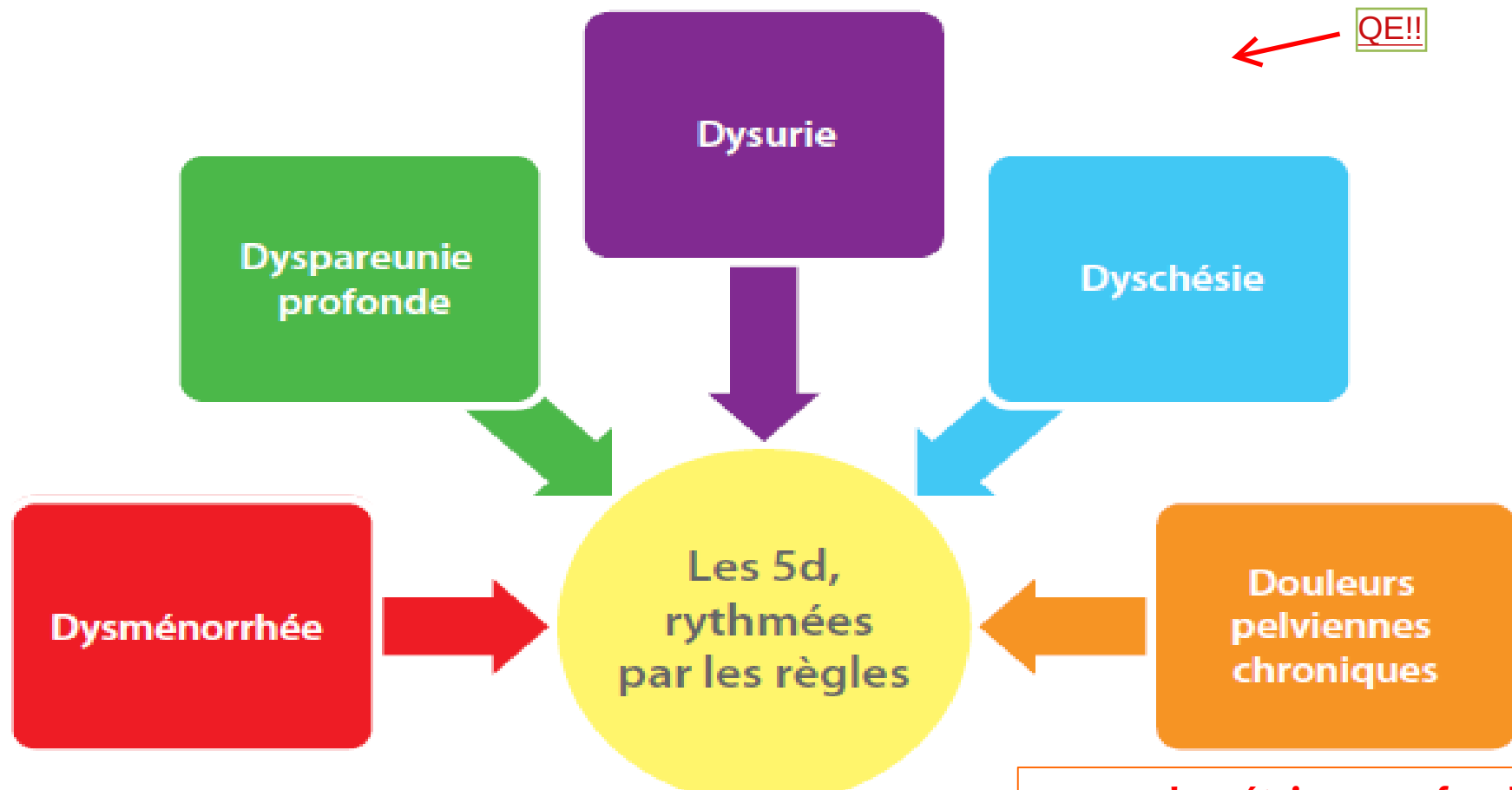


INTERROGATOIRE

1- Douleur +++++

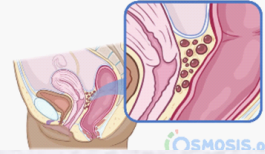


- Plainte douloureuse à caractère cataménial+++
- Xxxx consultations
- antalgiques simples : Inefficace
- Retentissement socio-professionnel et conjugal
absentéisme scolaire, professionnel
- Disparition de la douleur sous Contraception OP
- Pas de corrélation intensité/ sévérité des lésions



> 7 : endométriose profonde





signes
localisateurs
de E prof

- dysménorrhée tardive (2e-3e jour), secondaire, souvent associée à menorrhagies: adénomyose
- Dyspareunie prof post (US+ TORUS) majorée de façon cyclique (règles et ovulation) et POSITIONNELLE.
- Dysurie svt associée à pollakiurie
- Dyschésie
- Dlr ch: installation progressive insidieuse, pf quasipermanente (decharge électrique, crampes, brulures, coup poignard) **irradie : cuisse lombaires**.
- Autres localisations dlr vulvaire ou périnéale ou sur cicatrice de de laparotomie, dlr ombilicale.
- Echelle visuelle analogique, numérique : pré et post thérapeutique

INTERROGATOIRE

1 -douleur

2- Saignements génital : adénomyose

- Les ménorragies, très fréquentes 60 % des cas
- parfois saignotements péri-ovulatoires et prémenstruels
- Rarement métrorragies si nodules vaginaux
- s'aggravent au fil du temps

3- infertilité 50%

4- Autres signes évocateurs :hématurie, hémoptysie, toux cyclique , sciatalgie, réctorrhagie, DLR à la pointe de l'omoplate, gonflement+DLR à une cicatrice

5- comorbidités:

INTERROGATOIRE

5-Comorbidités: Syndromes associés:

- Syndrome de fatigue chronique (Insomnie, dépression)
- Migraine Mélanome++, chron, allergie, thyroïdite
- Syndrome de l'intestin irritable
- Discrète augmentation du risque : cancer (sein, ovaire, thyroïde)

EXAMEN CLINIQUE

Période menstruelle+++

1- Speculum: nodules bleuâtres : col et vagin , surtout

CDS vaginaux , cicatrice d'épisiotomie

- 2- toucher vaginal

- Uterus rétroversé fixé : adhérences /foyers endométrioses postérieurs

- taille de l'utérus: augmentée si adénomyose

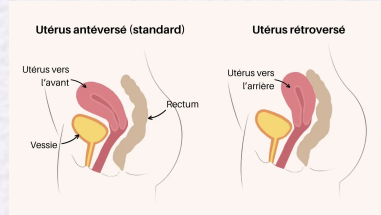
- dlr à la mobilisation utérine: adhérences

- rigidité des cul de sacs vaginaux

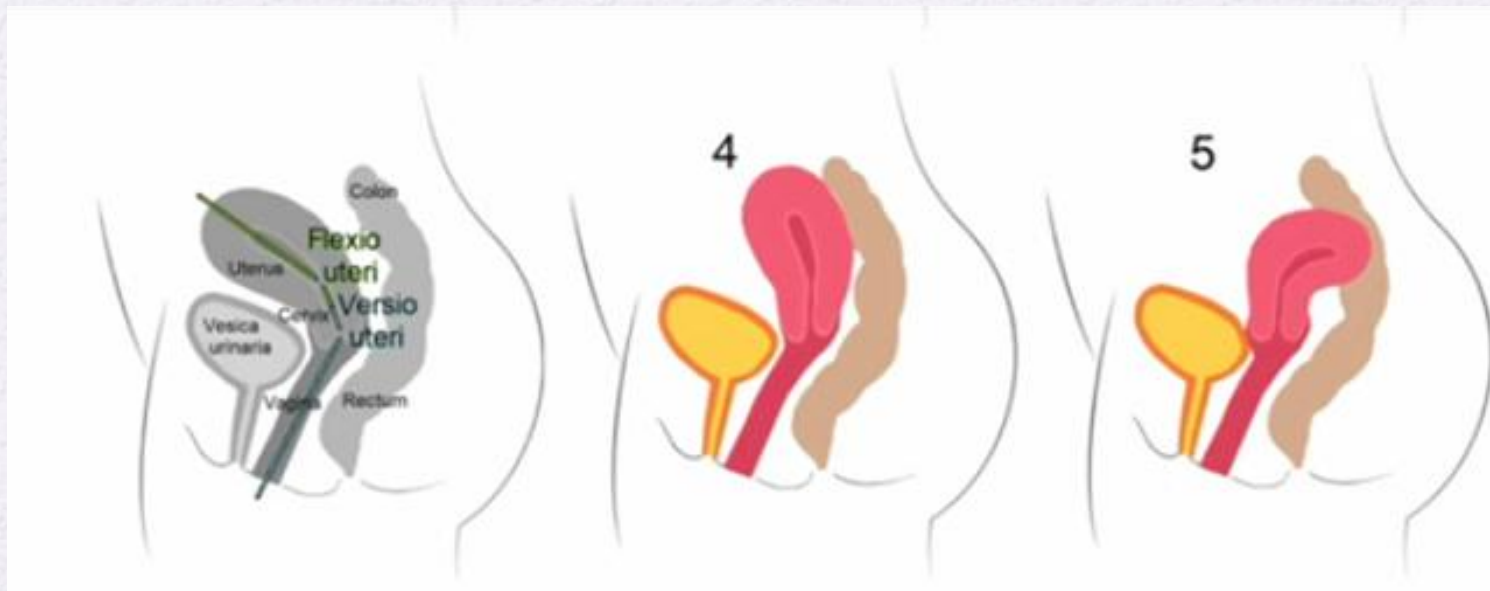
- Annexe sensible ou masse ovarienne (endométriome), fixité ?douleur?

- 3- toucher rectal noyaux douloureux infiltrant le Douglas surtt utéro-sacrés fibrosés

- 4- TR+TV: nodules de la cloison recto-vaginale



- Autres selon les symptômes retrouvés : examen de l'ombilic, cicatrice de laparotomie, de coelioscopie , pulmonaire...



examens complémentaires?

- Même si l'examen clinique est normale
- radiologues experts. ++++++

Échographie endovaginale+++

+suspubienne

- 1 ère intention +++++ (Si vierge: IRM)
- Vessie semi-pleine
- En dehors des menstruations (dysménorrhée limite l'évaluation de la mobilité des organes)
- Endovaginale+++Facilite la détection des foyers car réveille la dlr élective
- spécificité de 90 % or opérateur dépendant échographiste référent !
- Une cartographie complète.`
- Pas de parallélisme :sévérité des symptômes et la sévérité des lésions
- Points a rechercher :

- Adénomyose
- Annexes :Endometriome (partie apparente de l'ice burg)++, hématosalpinx
- Foyers E profonde
- Adhérences: signe du glissement
- Dilatation pyélocalicielle

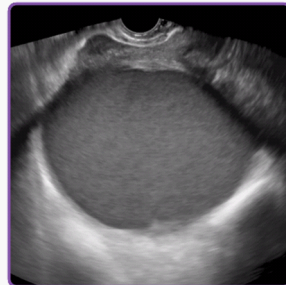
ENDOMETRIOMAS

US

- * CYST w/ HOMOGENEOUS ECHOGENICITY
└ "ground glass appearance"
- * 1-4 LOCULATIONS
- * NO SOLID COMPONENTS



ENDOMETRIOMA

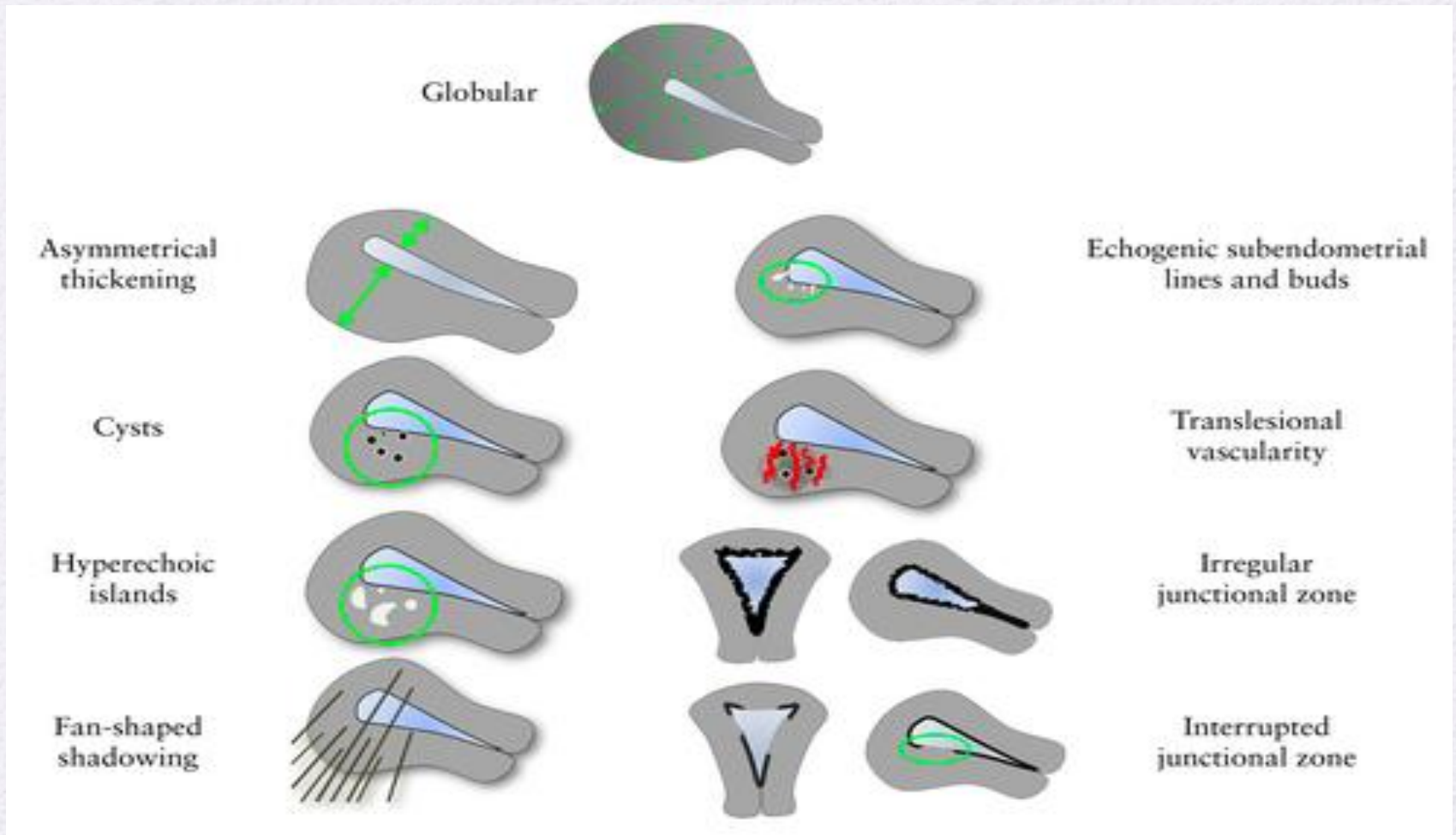


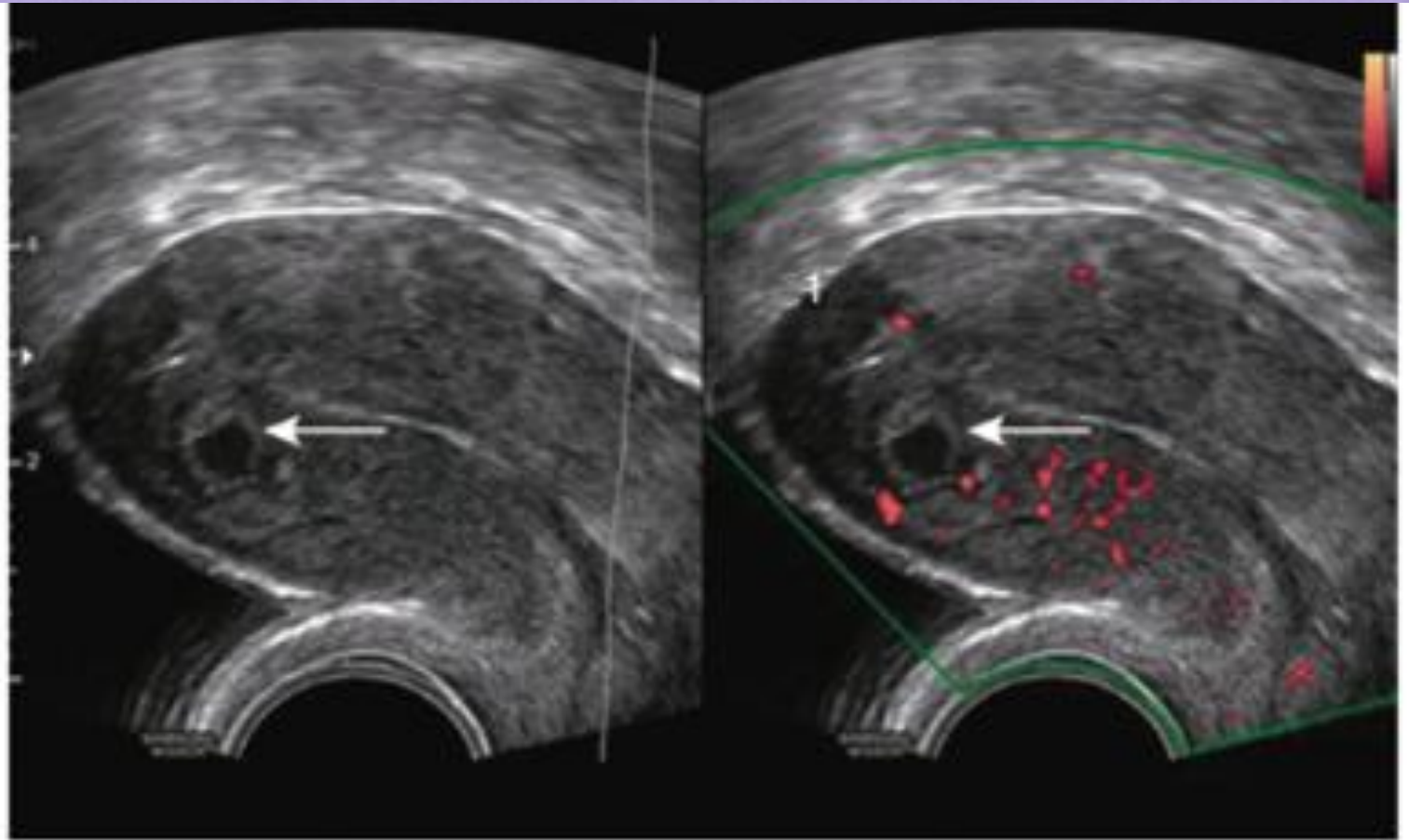
Adénomyose

MUSA CONSENSUS



QE!!

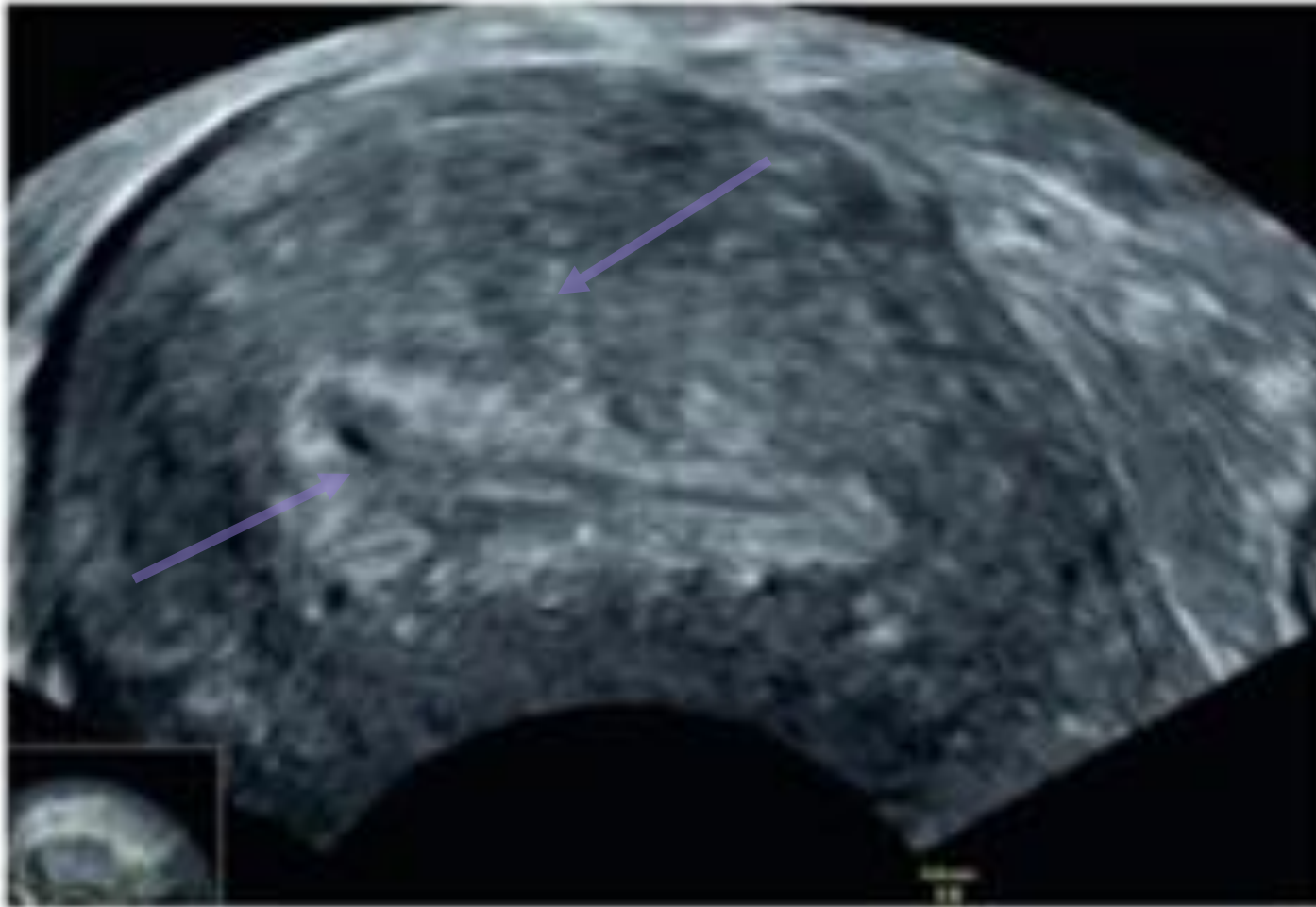




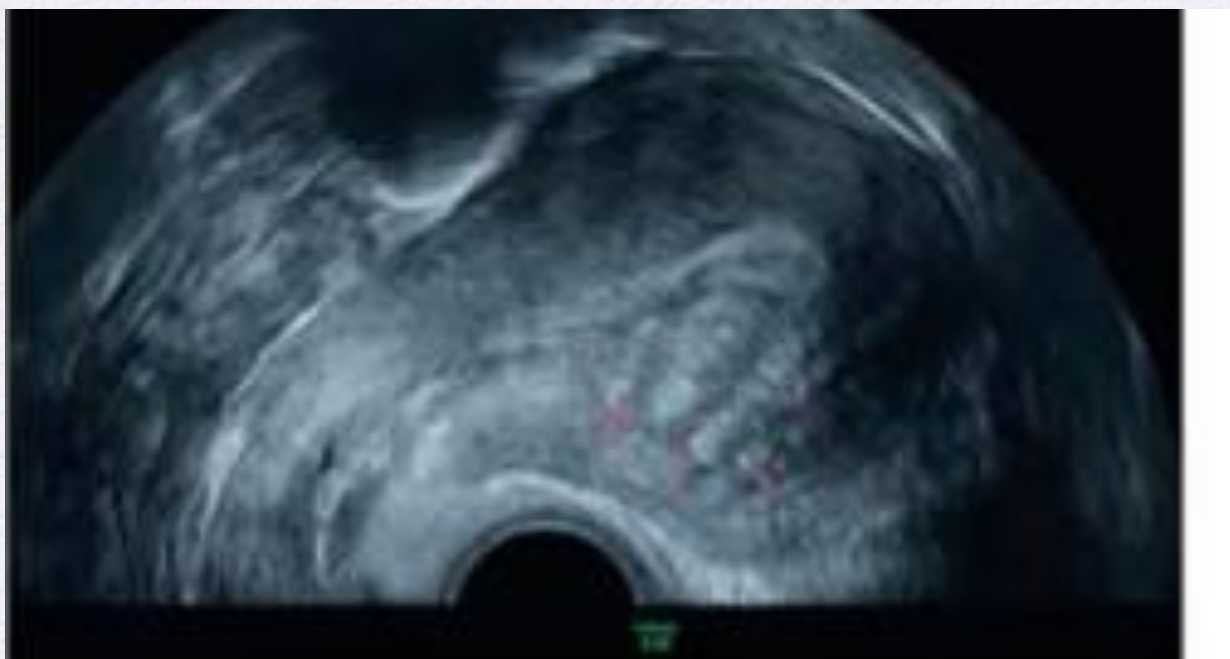
Adénomyose kystique Avec hypertrophie du stroma adjascent : hyperéchogène

- Adénomyose:

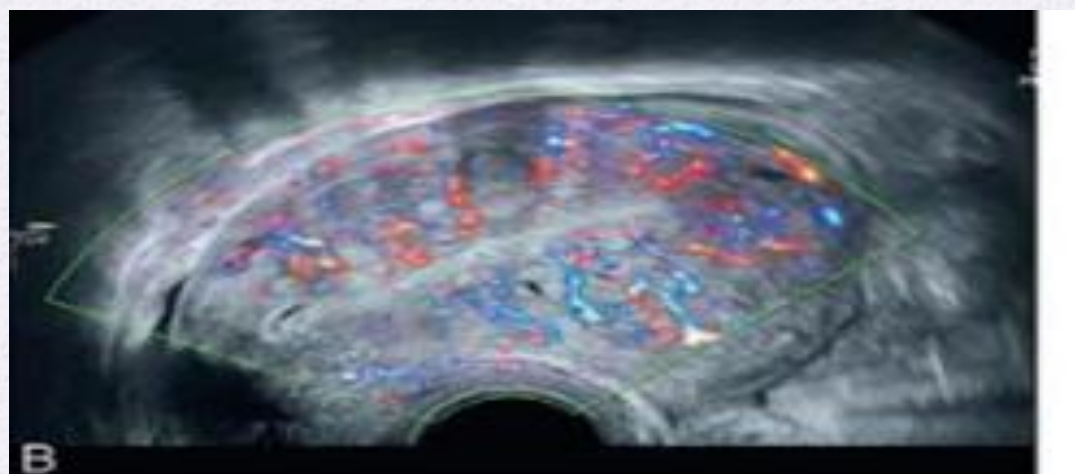


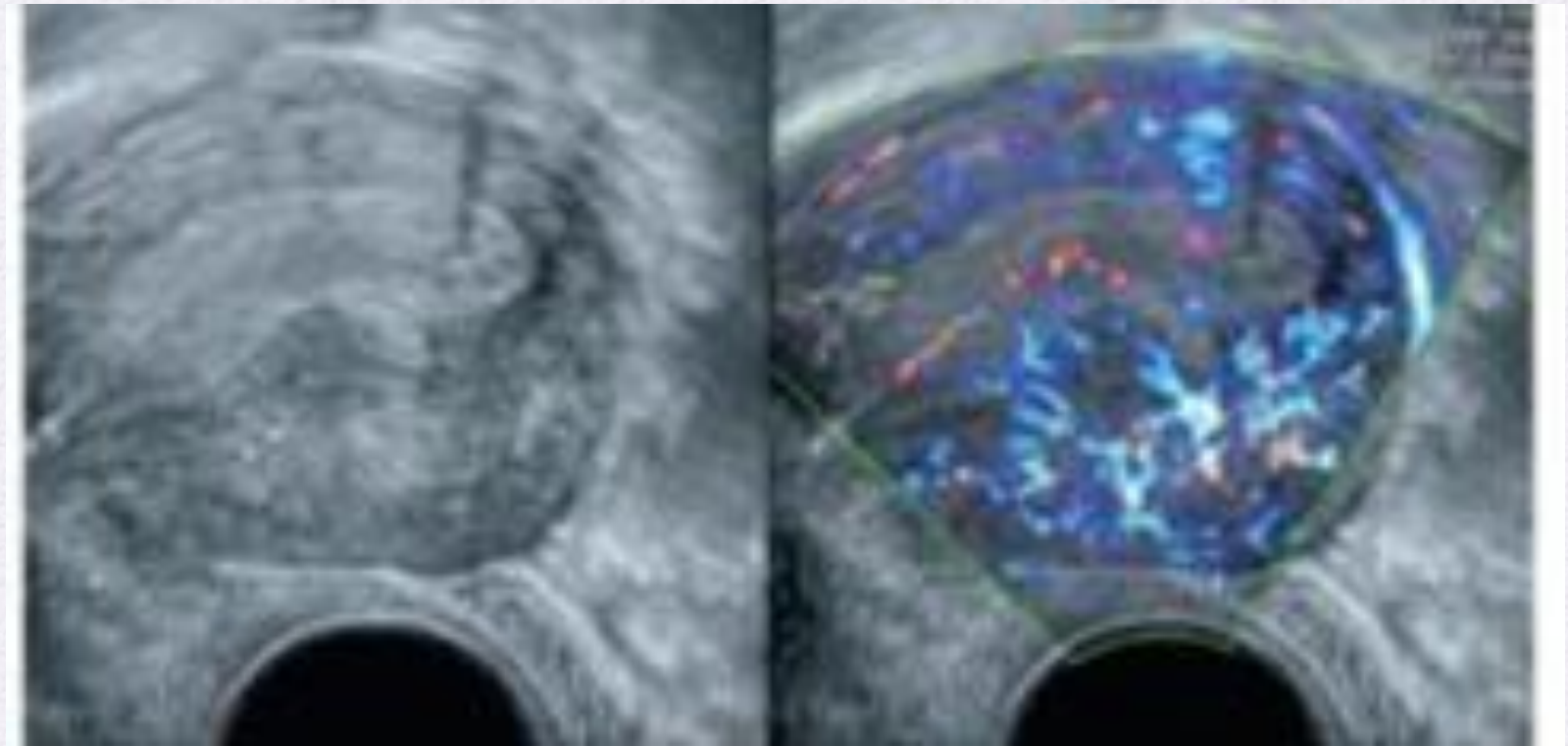


Jonction endomètre myomètre irrégulière mal limitée



Ilots hyperechogènes

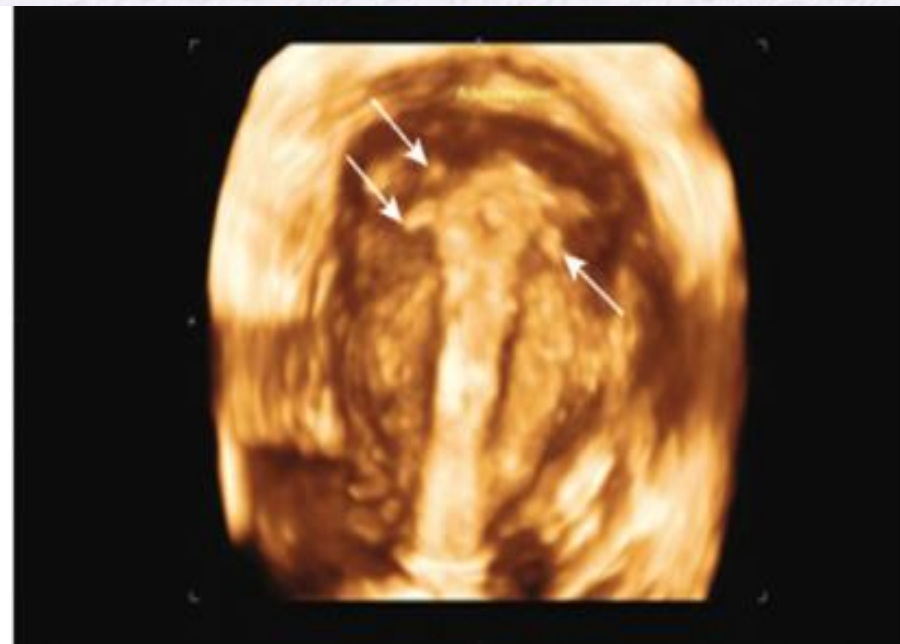
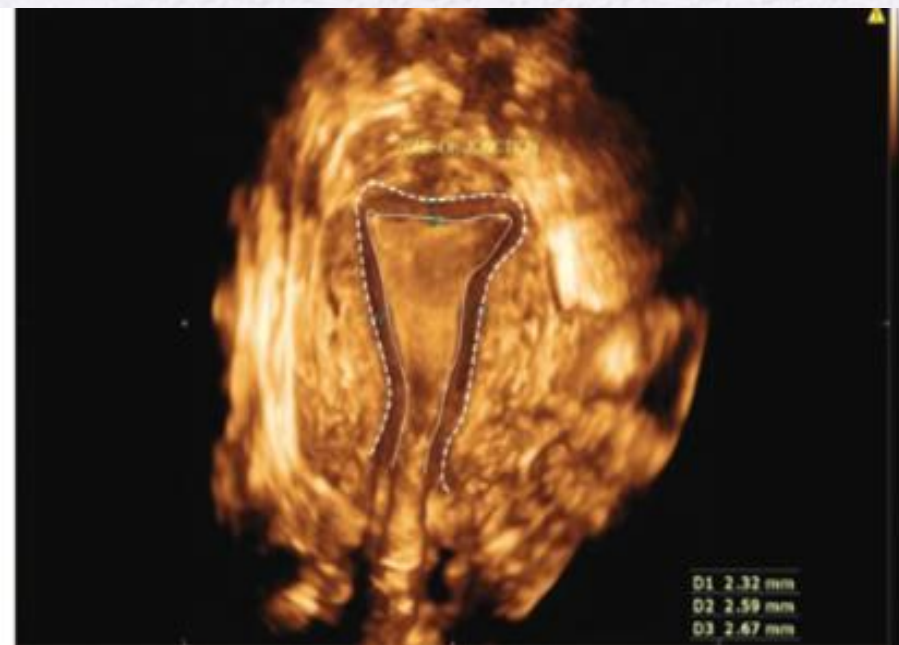




Adénomyose focale



3D





Endométriose externe :

Endométriome

- des kystes uniloculaires, liquidiens homogène finement échogène
« en verre dépoli »
- Paroi svt non vascularisée
- ? ménopause: Le diagnostic d'endométriome doit être posé avec prudence pour ne pas méconnaître une tumeur maligne
- ? La grossesse peut modifier l'aspect des endométriomes avec plus de cloisons et dans certains cas des papilles vascularisées
- Sa présence doit toujours faire rechercher de l'endométriose prof: partie apparente de l'ice berg++

ENDOMETRIOMAS

US

- * CYST w/ HOMOGENEOUS ECHOGENICITY
↳ "ground glass appearance"
- * 1-4 LOCULATIONS
- * NO SOLID COMPONENTS



ENDOMETRIOMA



EPITHELIAL OVARIAN TUMORS ENDOMETRIOMAS

- * From ENDOMETRIAL CELLS
- * BENIGN CYSTS that OCCUR in ENDOMETRIOSIS
- ENDOMETRIAL TISSUE from UTERUS GROWS on OVARY
↳ RESPOND to HORMONES → BLEED within CAVITY during MENSTRUATION → "CHOCOLATE CYSTS"
- * CAN RUPTURE & SPILL CONTENTS inside PERITONEAL CAVITY
- * RARE SUBCLASS: ENDOMETRIOID TUMOR
- MALIGNANT
- ENDOMETRIAL-LIKE GLANDS

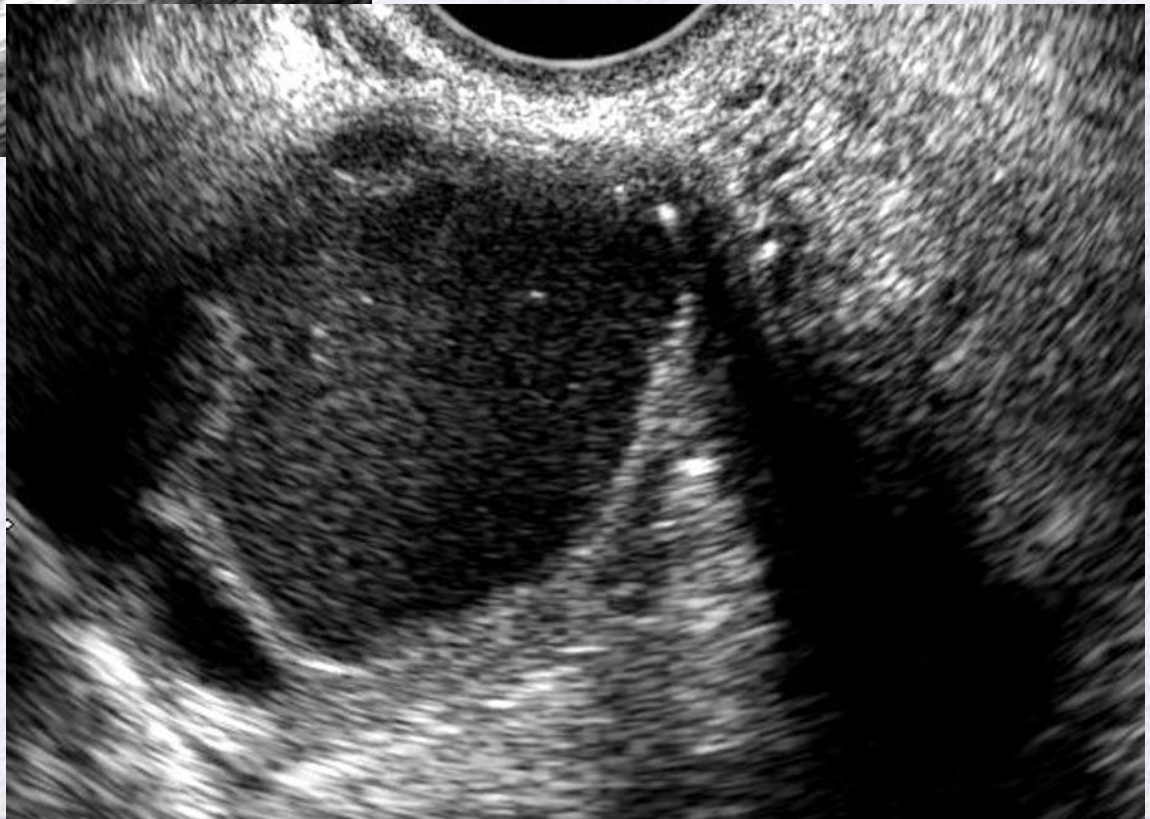


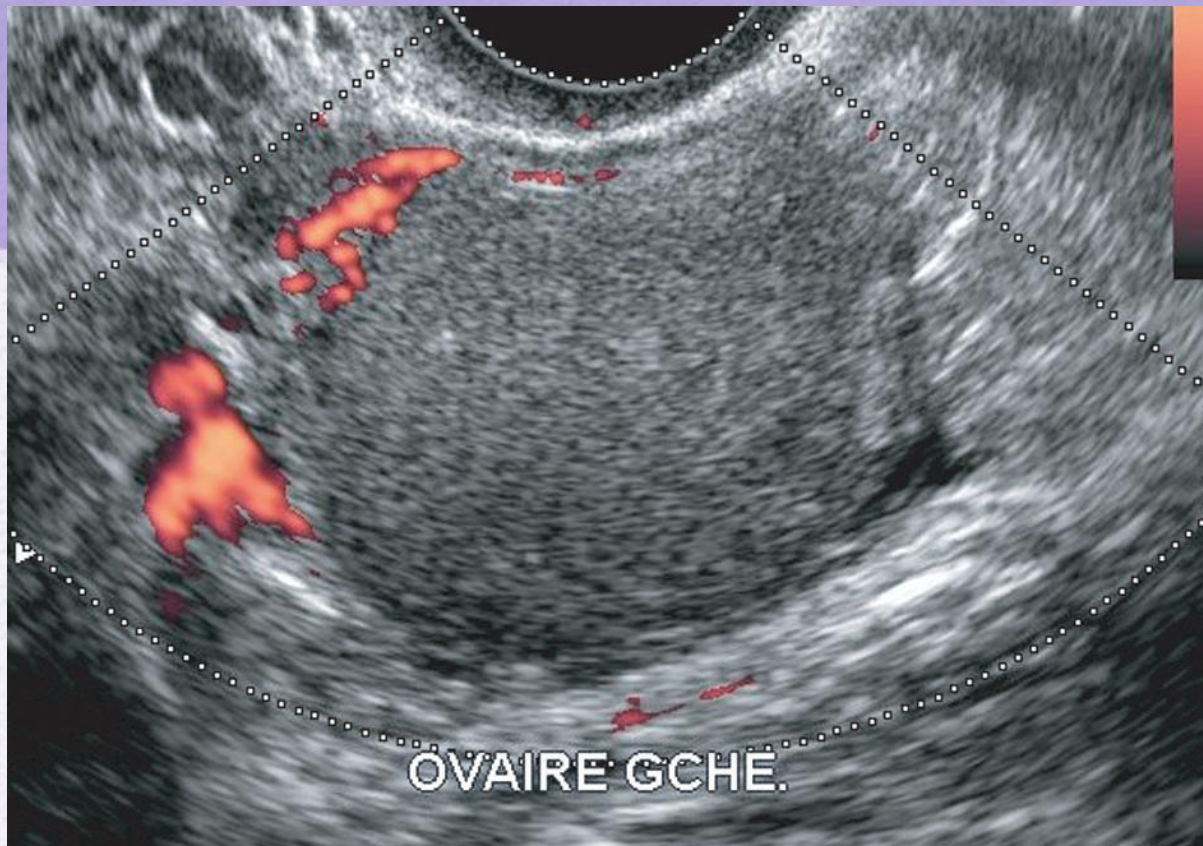


Lésion la plus facile à détecter

Endométriome jeune:
forme ovale, paroi fine
à peine visible.

Endométriome plus ancien :
paroi plus épaisse contours
géométriques
(adhérences périkytiques

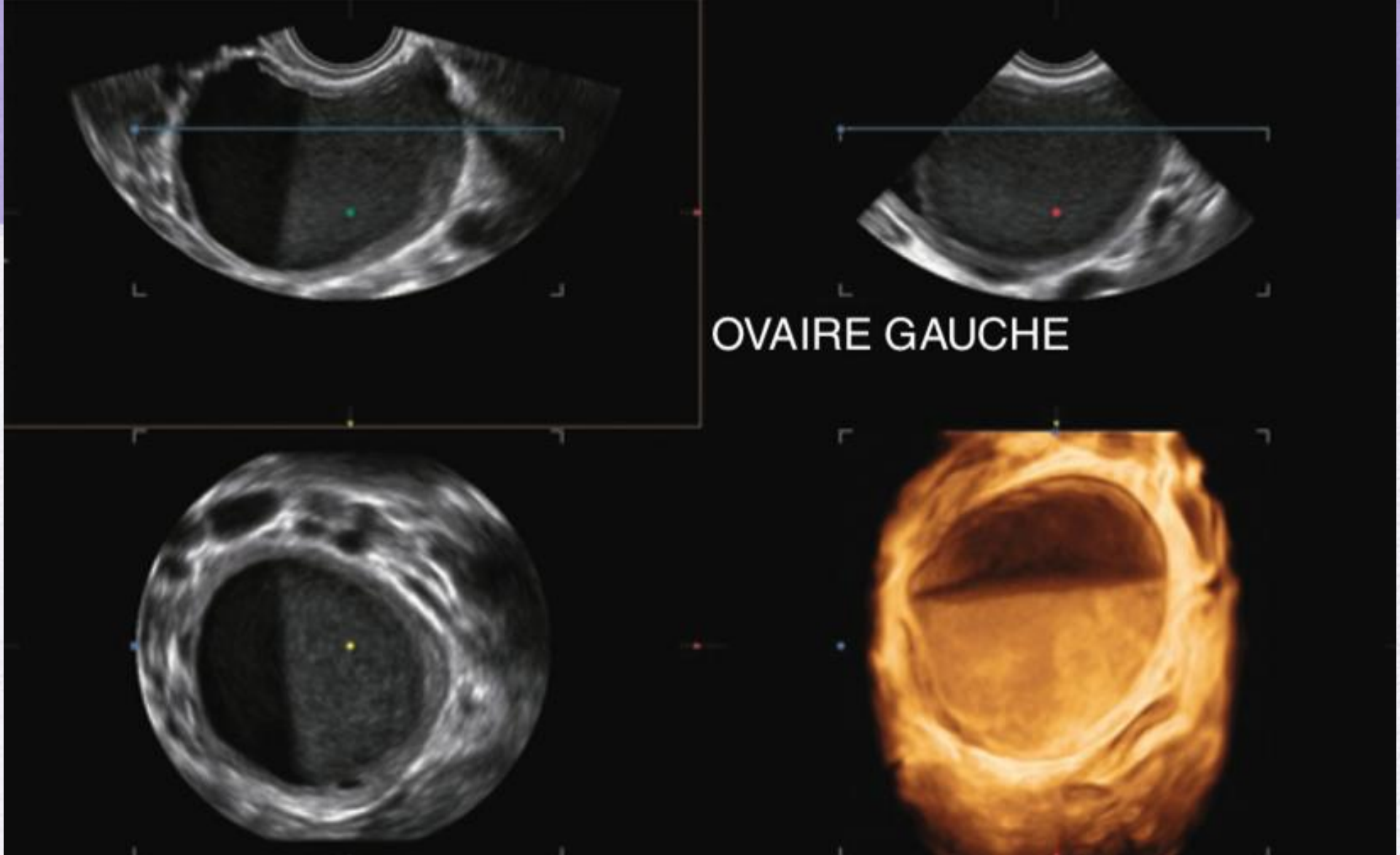




aspect homogène avec fins échos,
renforcement postérieur discret et
absence de signal en Doppler.



Saignement récent : sang de différent age



The image displays four 3D ultrasound views of the left ovary. The top-left view is a longitudinal section showing a large, dark, anechoic area, likely representing a blood-filled follicle or cyst. A horizontal blue line indicates a measurement across this area. The top-right view is another longitudinal section, showing a similar dark area with a red dot marking a specific point. The bottom-left view is a transverse section showing the circular cross-section of the ovary with a yellow dot in the center. The bottom-right view is a color Doppler image of the same transverse section, showing bright orange and red areas indicating blood flow within the ovary. The text 'OVAIRE GAUCHE' is centered between the top and bottom rows of images.

OVAIRE GAUCHE

Saignement récent : sang de différent age 3D



MATURE CYSTIC TERATOMAS

US

CYSTIC MASS w/ 1 or MORE of:

* MIXED ECHOGENICITY

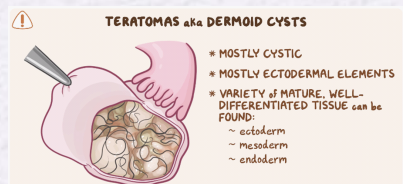
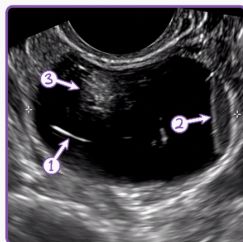
① THICK BAND-LIKE INTERNAL ECHOES

② FAT FLUID LEVEL

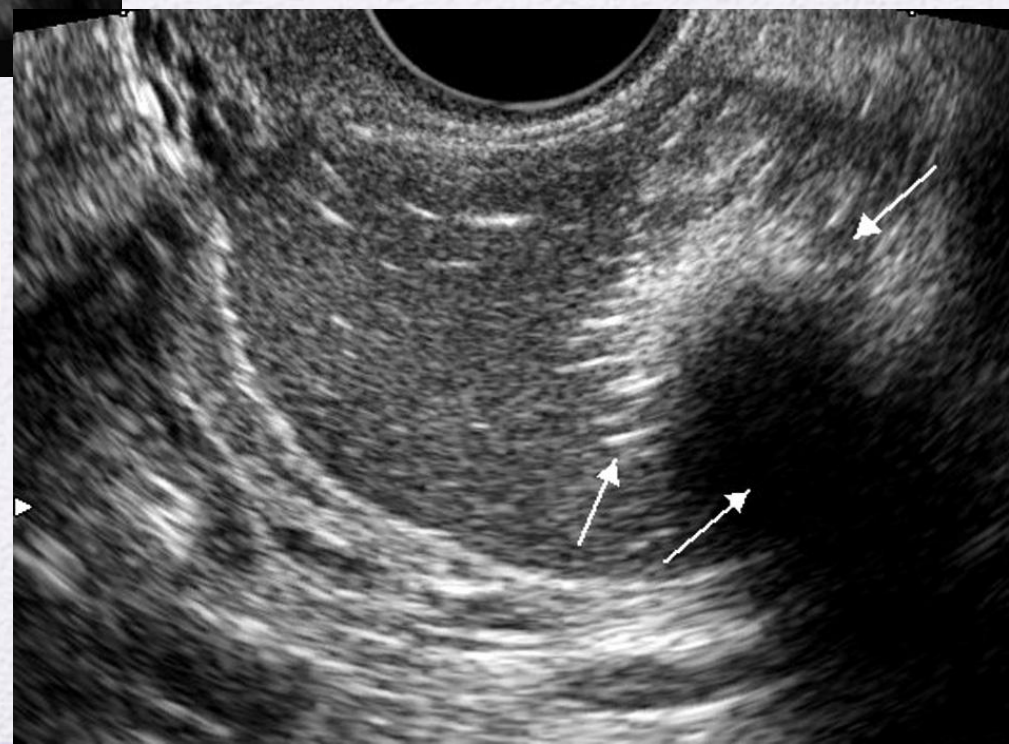
③ ECHOGENIC NODULE w/ POSTERIOR SHADOWING

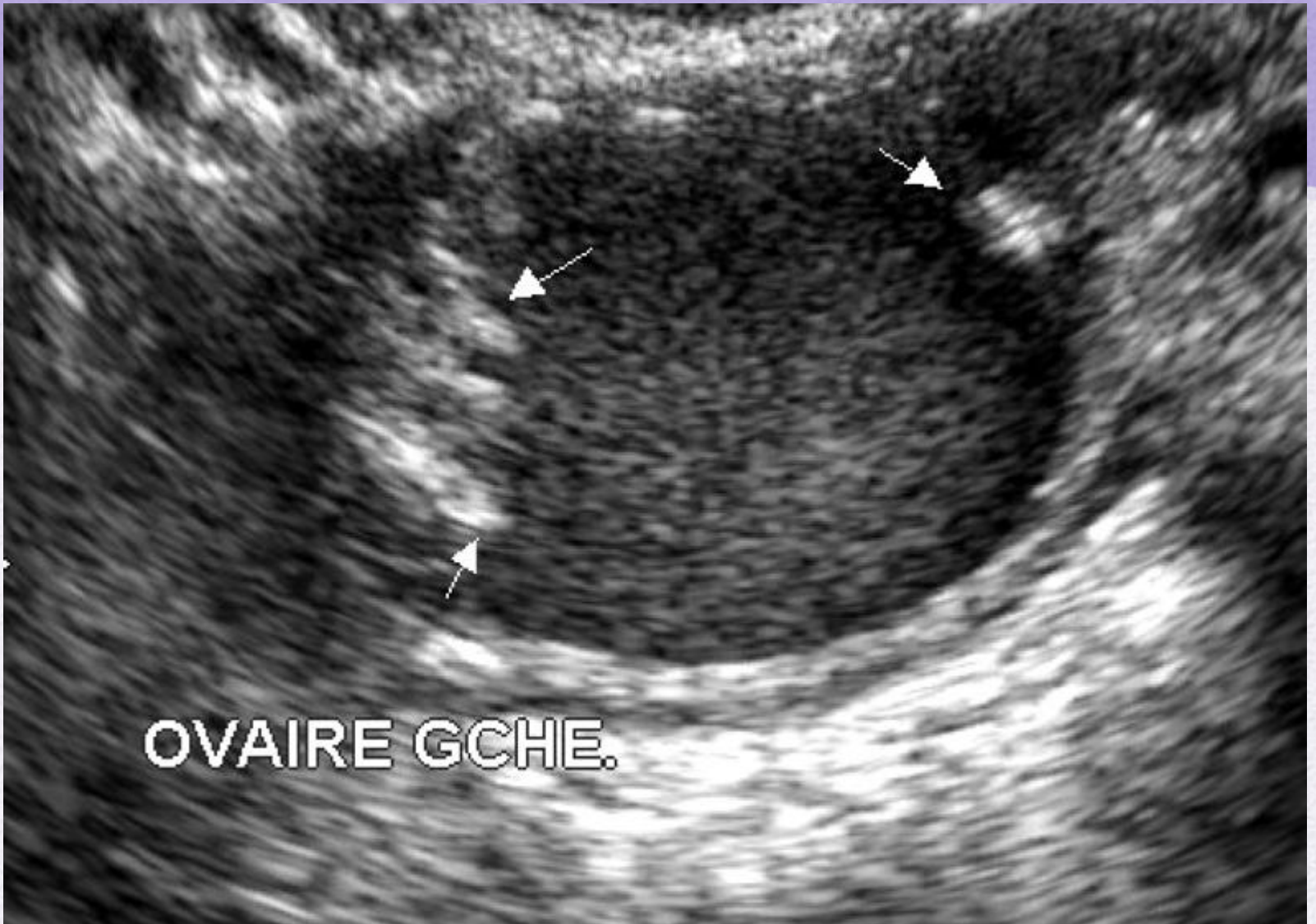


MATURE CYSTIC TERATOMA

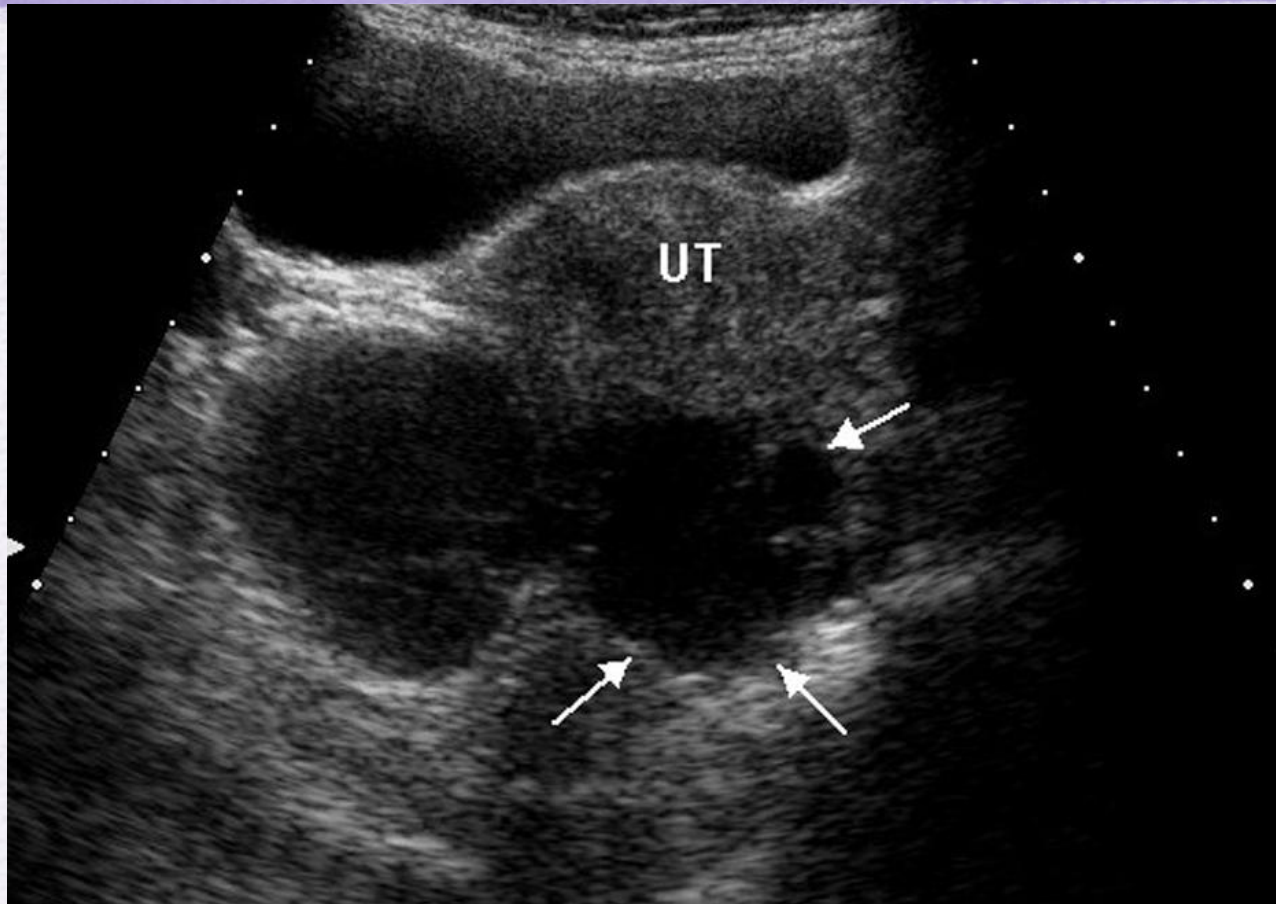


Nodule rokitansky





d'hémosidérine: Ponctuations échogènes intrapariétales
(?)

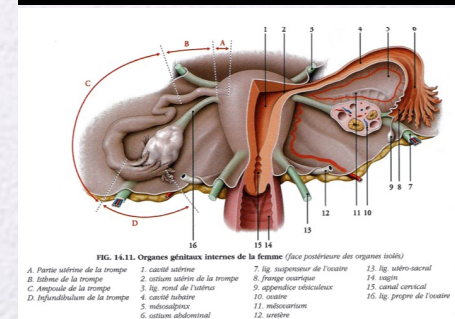
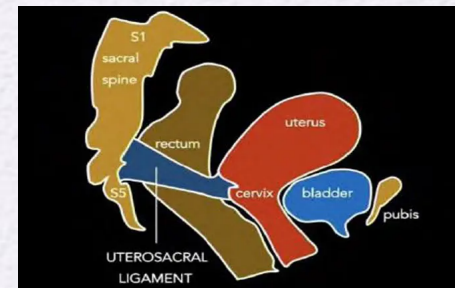


Kissing ovarien

Endométriose externe

Sous Péritonéale profonde

- Endovaginale vesie semi-remplie +- préparation digestive et produit de contrast rectal pour l'atteinte digestive
- Recherche:
 - Atteinte vésicale , urétérale, pyélo-calicielle
 - Torus , utérosacrés++++ très fréquente
 - Digestive : rectum+
- Signes echographiques:



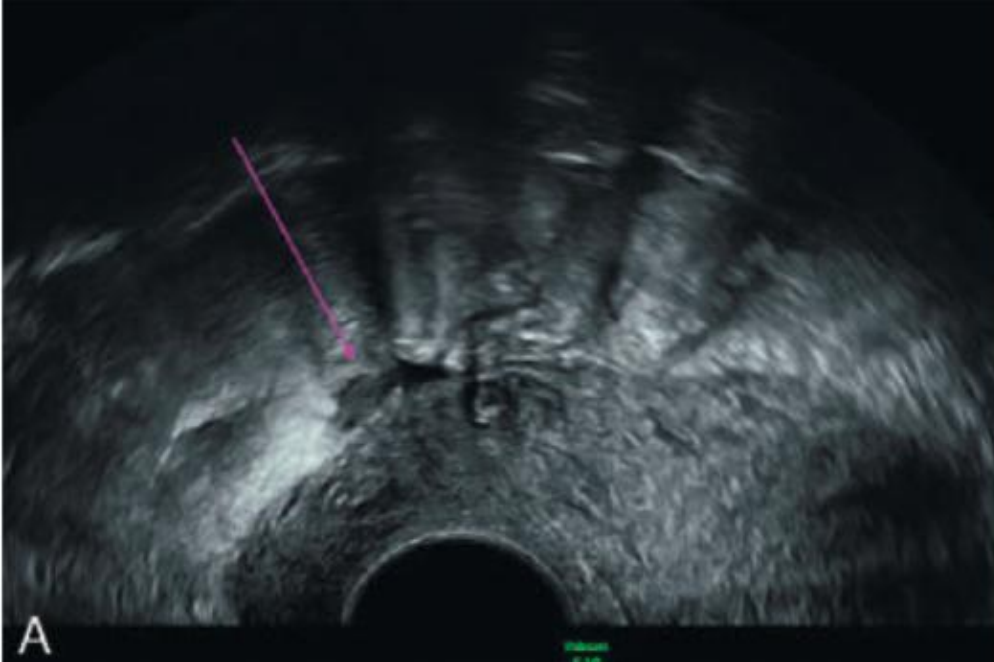
- Image

- **hypoéchogène spiculée** pouvant contenir en son centre quelques punctums hyperéchogènes.

- Non ou très peu vascularisé

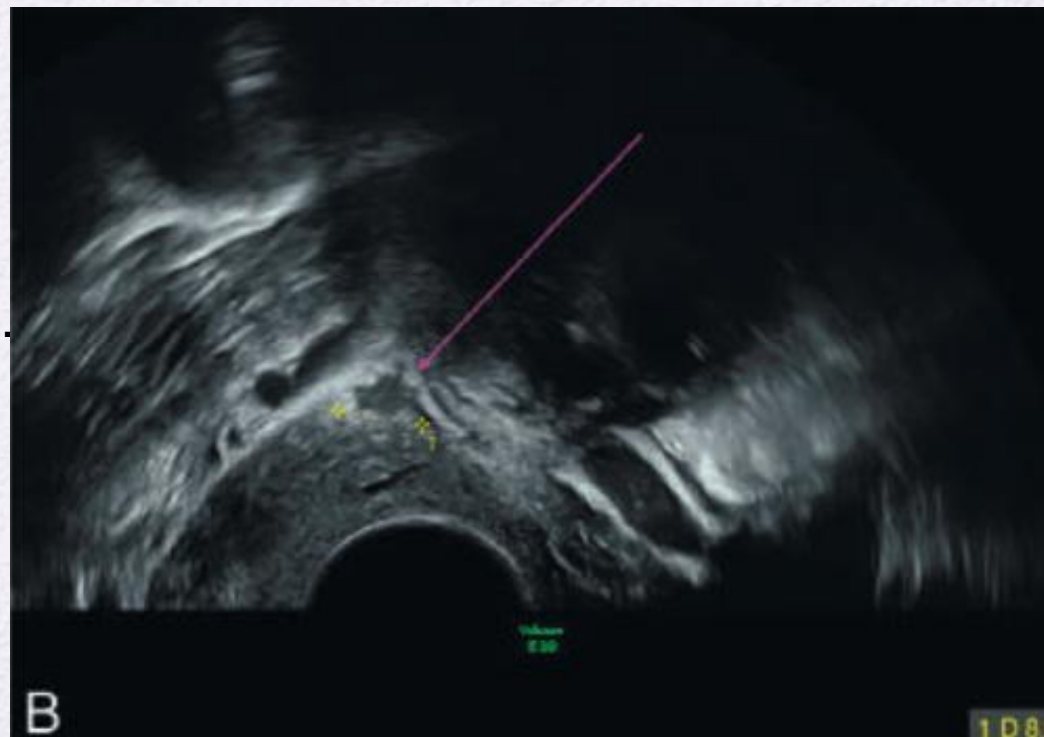
- On recherche en mobilisant l'utérus, des **adhérences avec la face antérieure du rectum** en arrière.

- recherche **d'un nodule rectal** + éventuelle extension à la musculuse

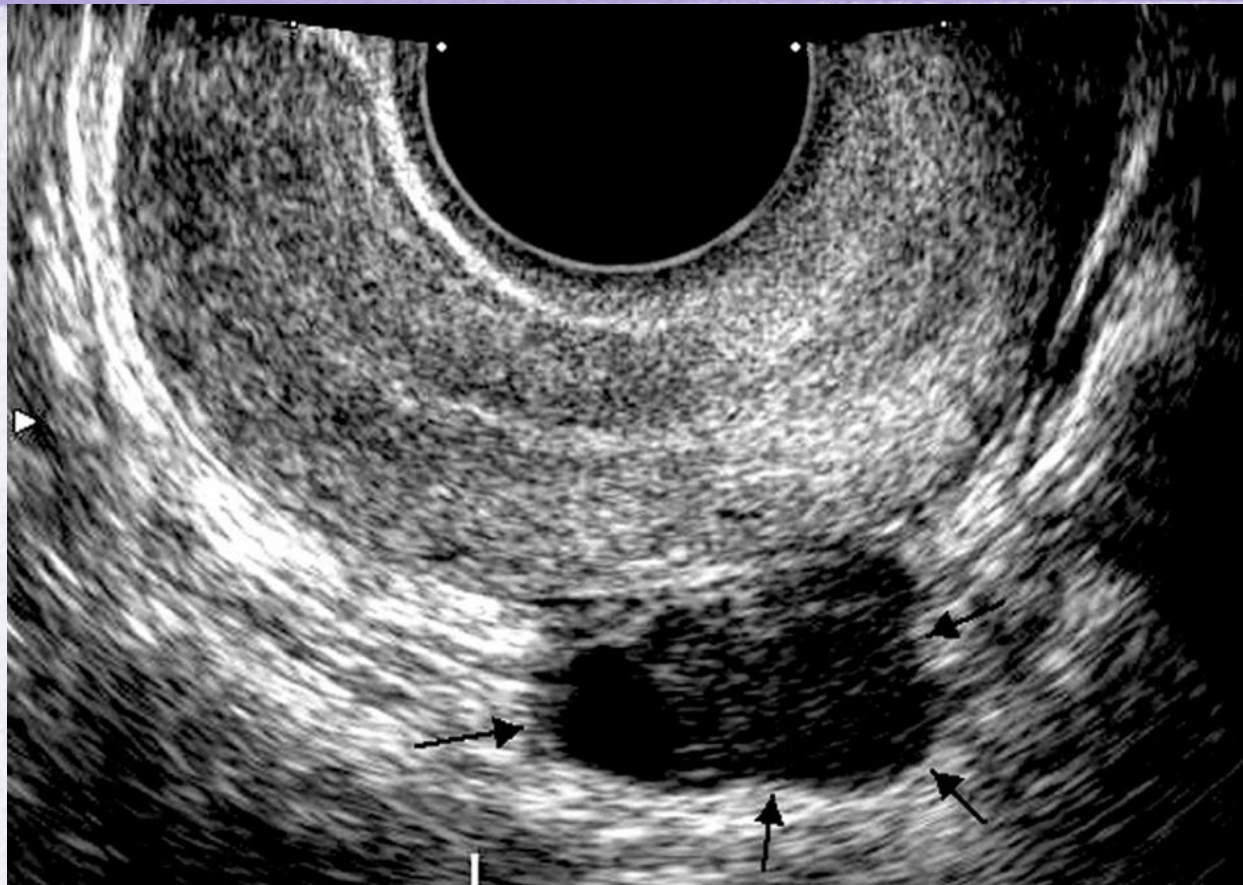


A. Coupe sagittale.

Petit nodule à l'insertion des
utérosacrés en rétro-isthmique
légèrement paramédian gauche (flèche).



B. Coupe transverse



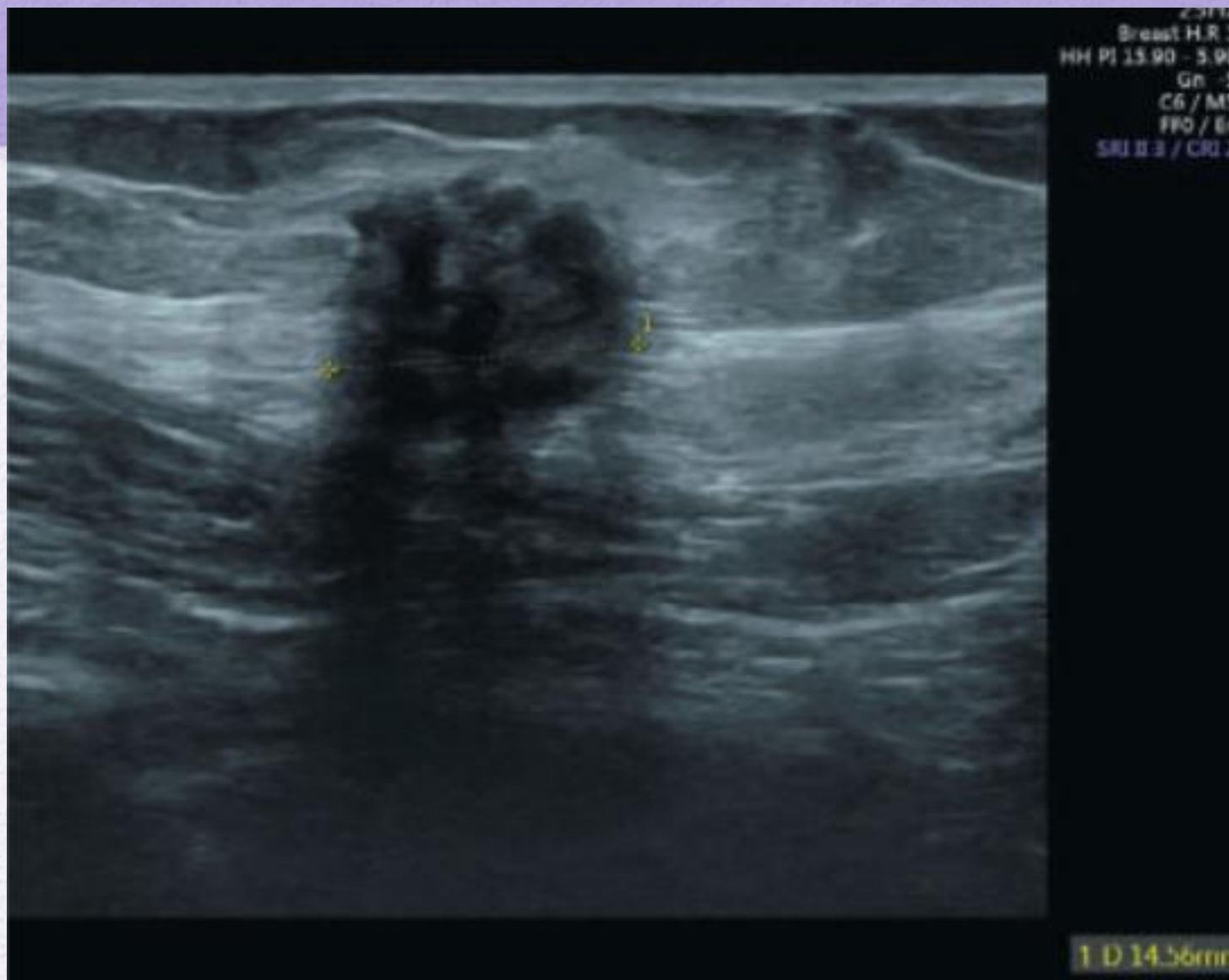
douglas



Endovag

Vessie semiremplie

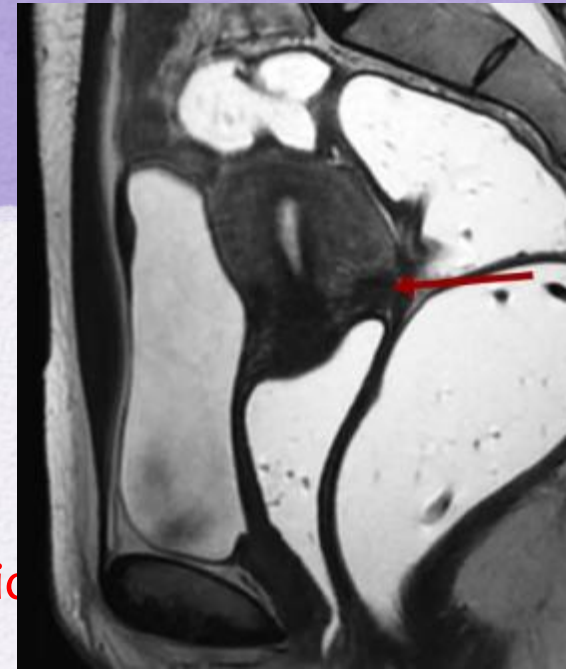




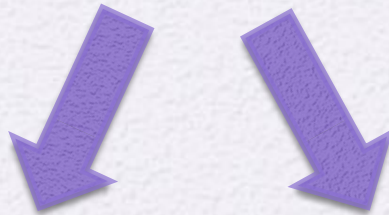
Nodule endométriosique isolé de la paroi abdominale antérieure au niveau du muscle grand droit

I'IRM

- Supérieur à l'échographie si echographe non expert
- Vessie selmi-remplie
- balisage vaginal et rectal Sensibilité spécificité+++
- Endometriose profonde , endométriome infracentimétrique et localisations digestives asymptomatiques dans 30%des cas)
- Faux négatifs!!!! pour E . Péritonéale superficielle! +++++++
- Degré d'infiltration des organes ++++: choix TTT
- distinguer l'adénomyose externe/ l'adénomyose classique



Diagnostic



Clinique + écho +/- IRM

coelioscopie?!

Coelioscopie : Indication

Lorsque l'imagerie objective une endométriose : pas lieu de réaliser une coelioscopie dans le seul but de confirmer le diagnostic par biopsie: l'histologie n'est plus obligatoire pour le diagnostic +++

- En cas de suspicion clinique d'endométriose alors que l'imagerie est négative

(TEST diagnostic : traitement médical d'épreuve possible)

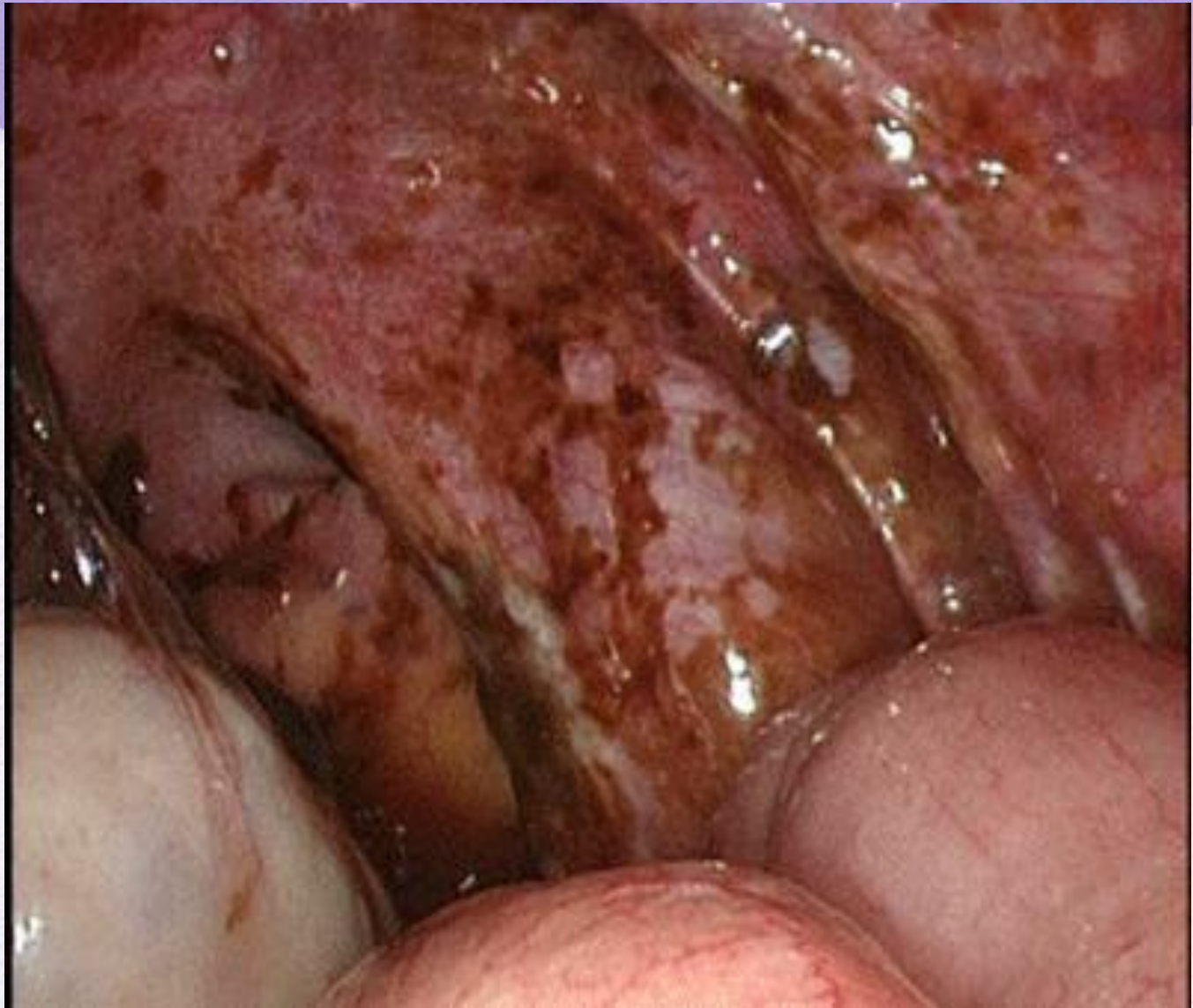
- Si imagerie négative et pas de réponse au TTT
- Doit s'intégrer dans une stratégie de traitement des douleurs ou de l'infertilité.+++

Au cours de la coelio:

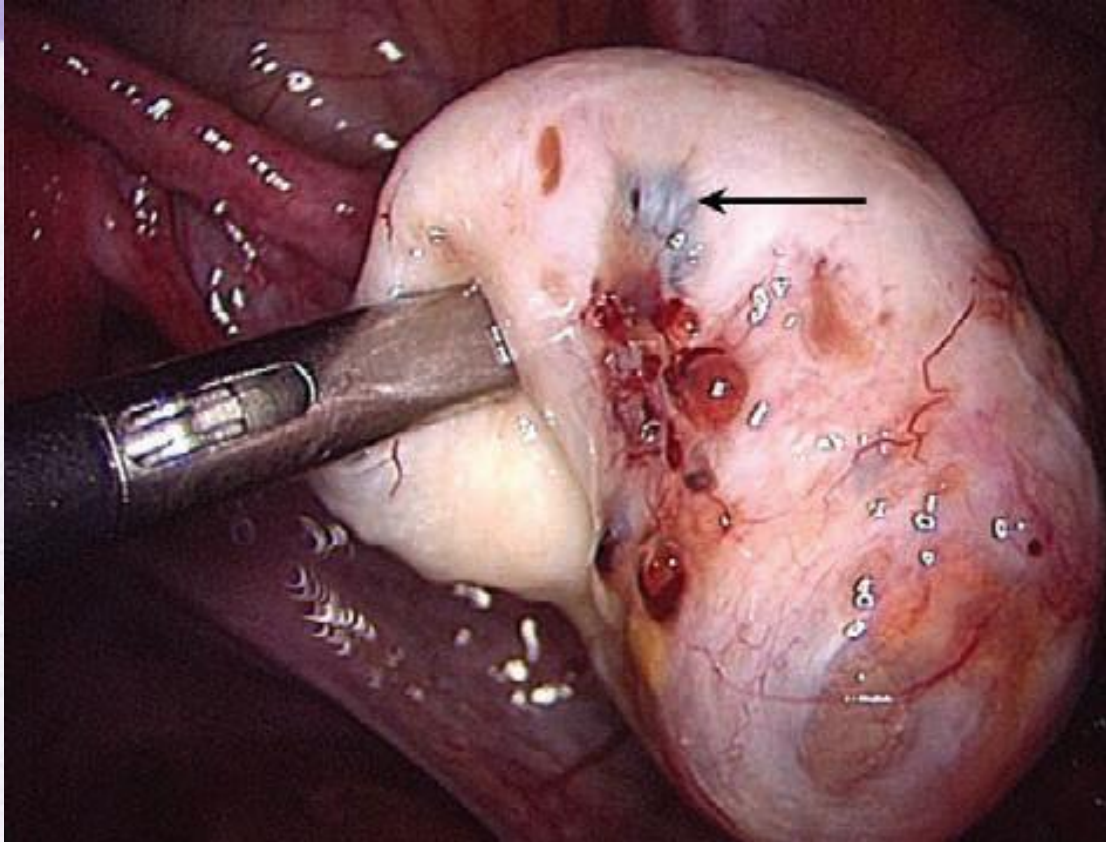
- **Aspects:** Lésions bleuâtres –saignantes- blanchâtres en étoiles
- Exploration: Faire une **description exhaustive et précise** de la cavité abdomino-pelvienne :

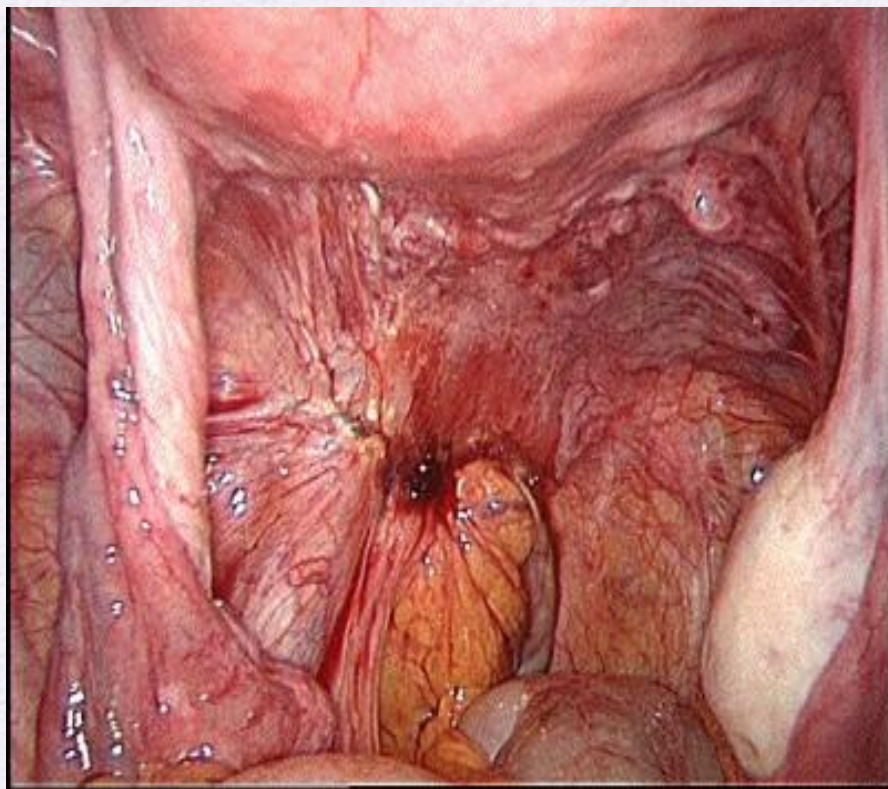
(Adhérences ,différents types de lésions ,description macroscopique, leur taille, localisation)

- Réaliser des **biopsies** dirigées (avec examen **anatomopathologique**)
- **Anapath négative** n'exclut pas le diagnostic
- **Utiliser des classifications lésionnelles** pour décrire l'étendue de l'endométriose et faciliter les échanges interprofessionnels

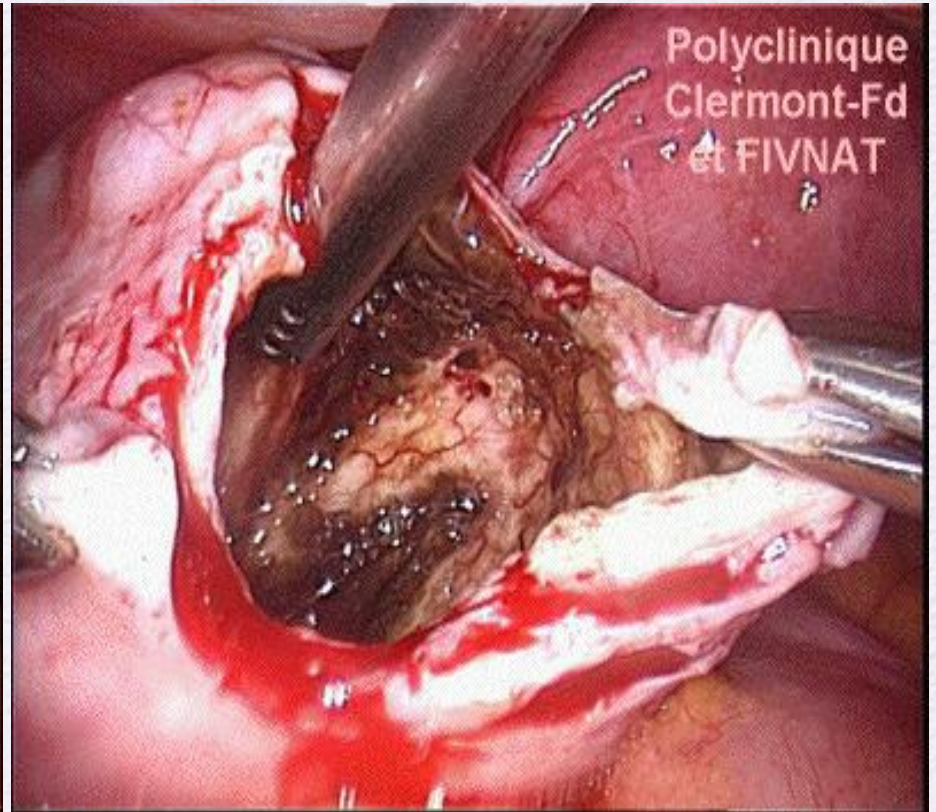
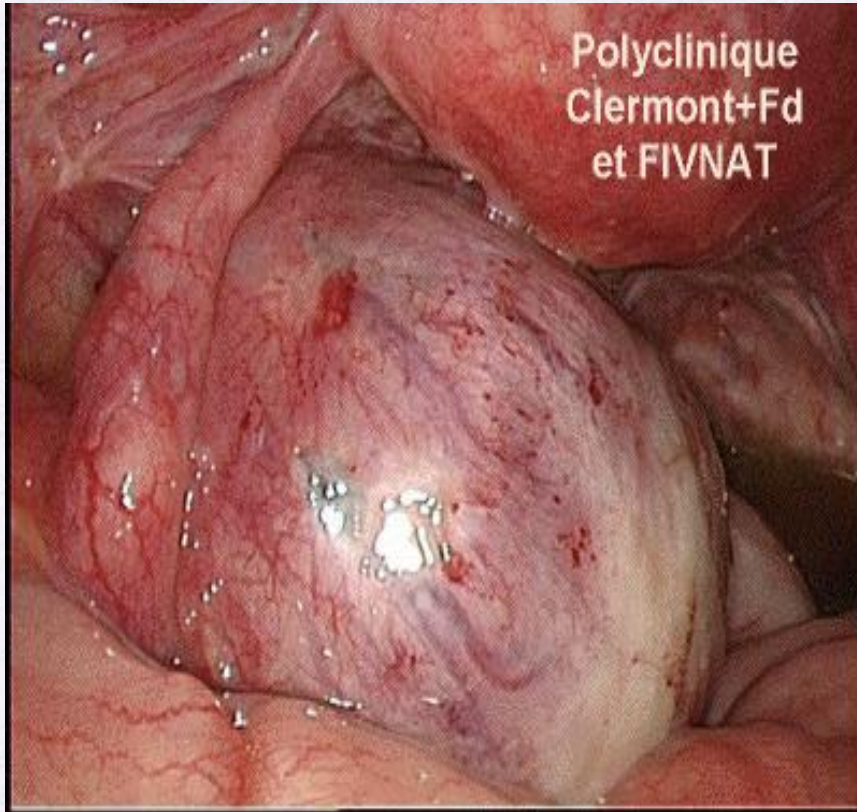


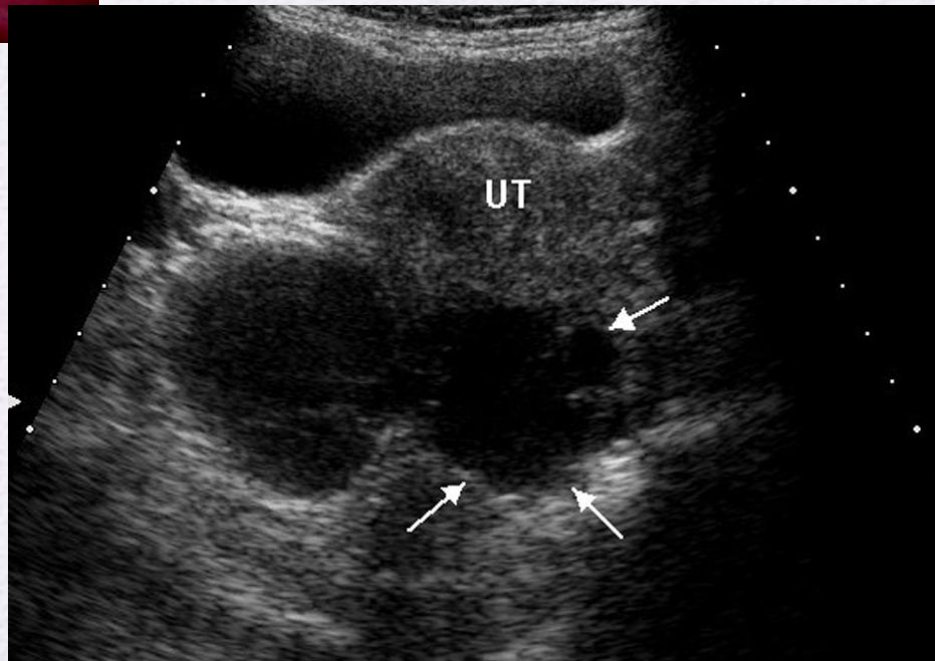
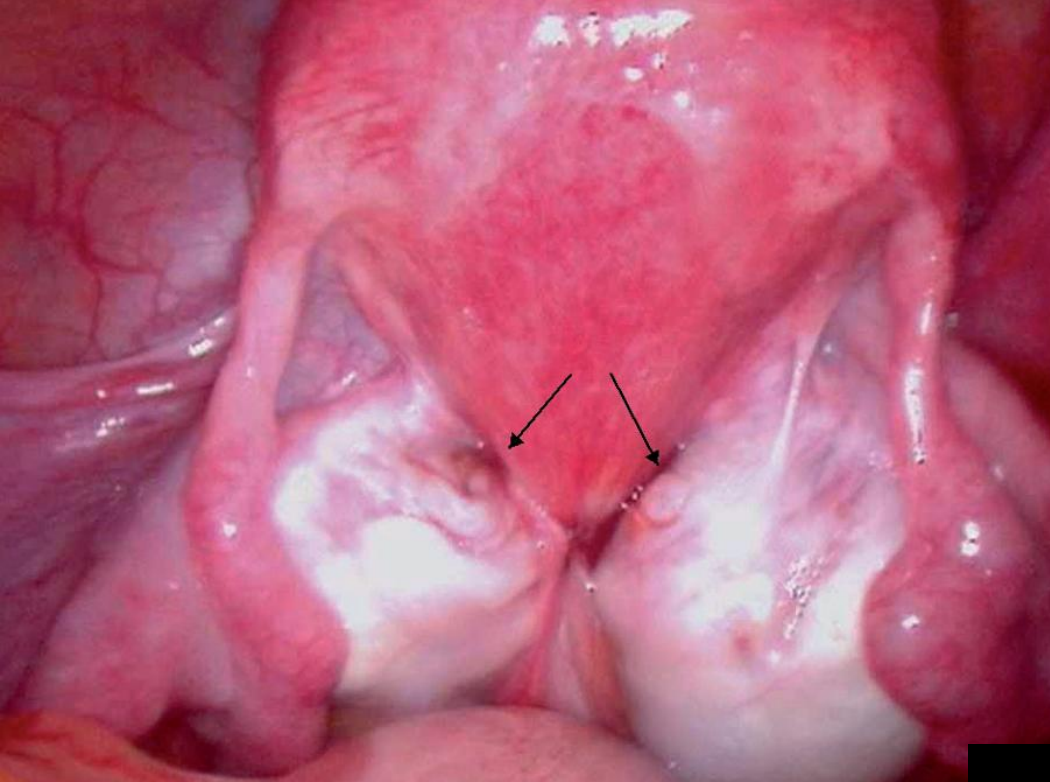
Rouge et noire





endométriose

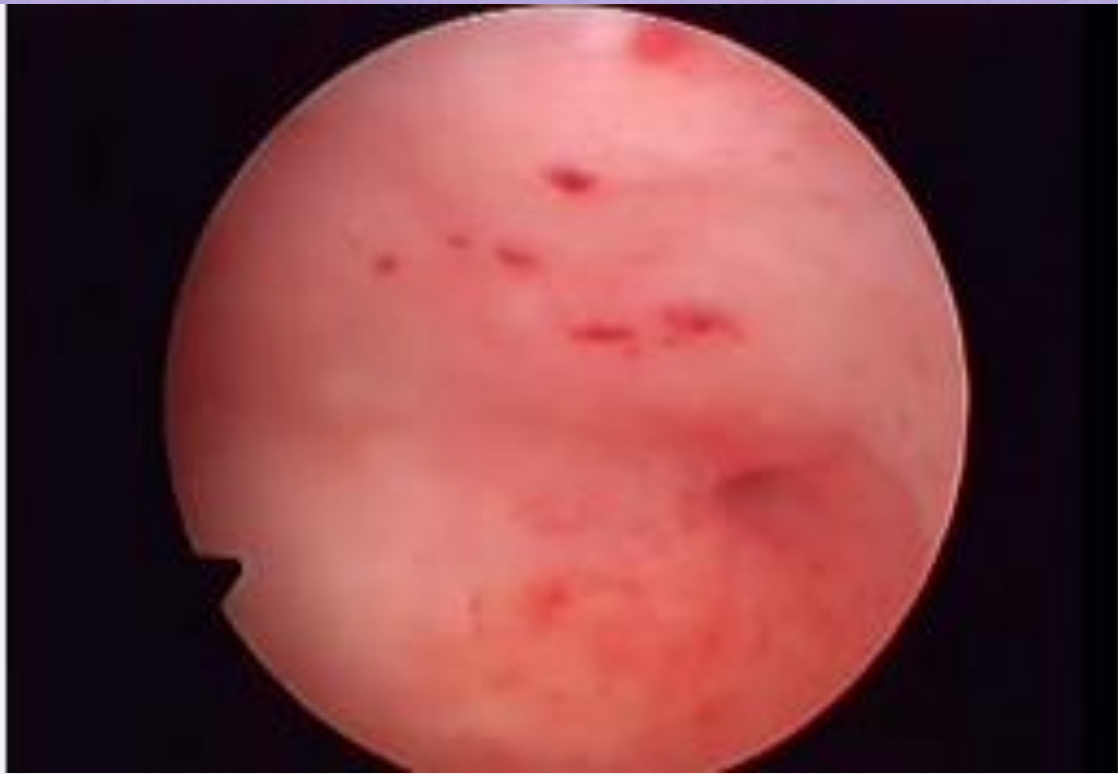




Hystéroskopie ?

Hystéroscopie si adénomyose

- petits orifices punctiformes correspondant aux canaux diverticulaires
- Nodules bleuâtres
- Ectasie préostiale
- aspect en colonnes (Hypertrophie myométriale)
- Signes inconstant+++++



DEMARCHE DIAGNOSTIQUE

- L'approche moderne : diagnostic clinique-radiologique
- Radiologie de 1^{ère} intention: échographie pelvienne .
- Radiologie de 2^{ème} intention: Si signes orientateurs d'endométriose prof, infertilité, endométriose:
échographie par un échographiste référent ou IRM
- Radiologie de 3^{ème} intention Si signes cliniques+ echo + IRM normale
 - une échographie rectale (EER) : localisations recto-sigmoïdiennes
 - un colo-scanner (colo-CT): colon

stadification

- Multiples classifictations
- Complexes
- Parfois se complètent

la classification révisée de l'American Society for Reproductive Medicine (rASRM)

- classification est destinée principalement à être utilisée pour les patientes d'endométriose consultant pour infertilité, mais **ne reflète pas l'Endométriose prof , adénomyose**
- de moins en moins utilisée
- moins reproductible
- peu corrélé à la fertilité potentielle

Endométriose		< 1 cm	1 à 3 cm	> 3 cm
Péritonéale	Superficielle	1	2	4
	Profonde	2	4	6
Ovarienne droite	Superficielle	1	2	4
	Profonde	4	16	20
Ovarienne gauche	Superficielle	4	2	4
	Profonde	4	16	20
Oblitération du Douglas		Partielle : 4 Complète : 40		
Adhérences par rapport à la circonférence		< 1/3	1/3 à 2/3	> 2/3
Ovariennes droites	Transparentes	1	2	4
	Opaques	4	8	16
Ovariennes gauches	Transparentes	1	2	4
	Opaques	4	8	16
Tubaires droites	Transparentes	1	2	4
	Opaques	4	8	16
Tubaires gauches	Transparentes	1	2	4
	Opaques	4	8	16
Stade I (minime) : 1–5. Stade II (modéré) : 6–15. Stade III (moyen) : 16–40. Stade IV (sévère) : > 40				

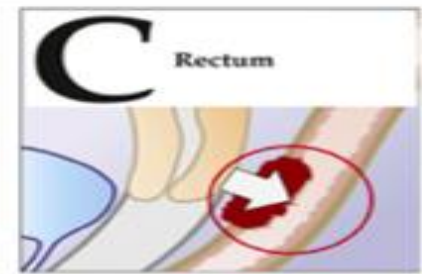
enzian

- corrélation significative entre la classification ENZIAN (IRM) et l'étendue de la maladie, la difficulté et la durée de l'intervention ainsi que la sévérité des symptômes
- L'IRM est corrélée au score ENZIAN chirurgical et est très précise dans la détection la localisation de l'E prof
- une stadification préopératoire correcte.
- Mais encore peu utilisée par les praticiens

ENZIAN 2012

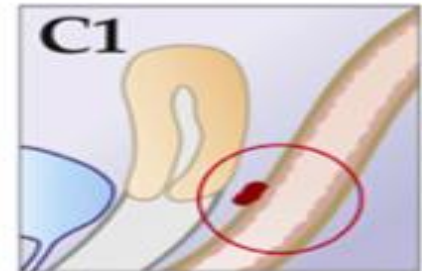
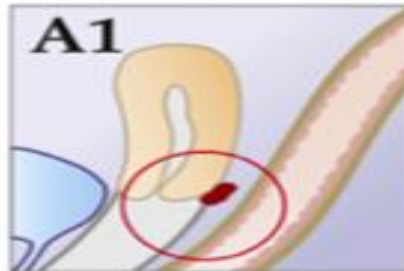
Classification of Deep Infiltrating Endometriosis (according to the Endometriosis Research Foundation, SEF)

Compartment
A, B or C

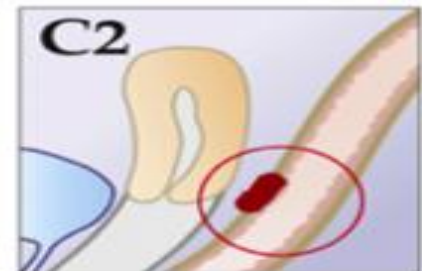


Level

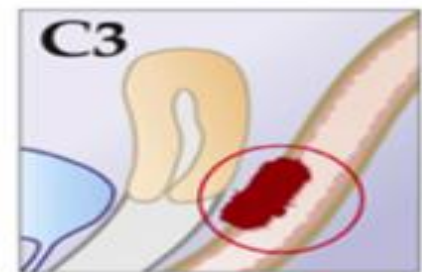
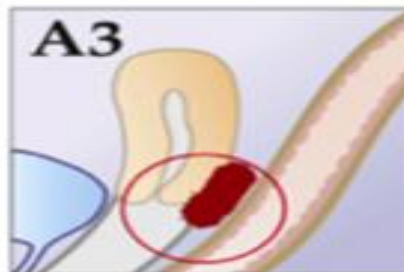
1
< 1 cm

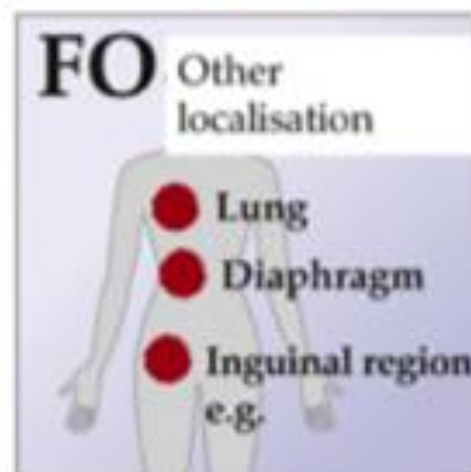
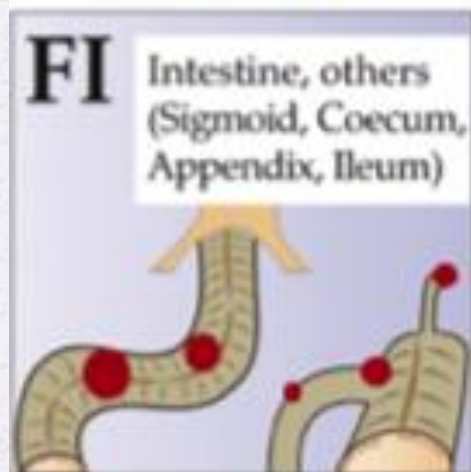
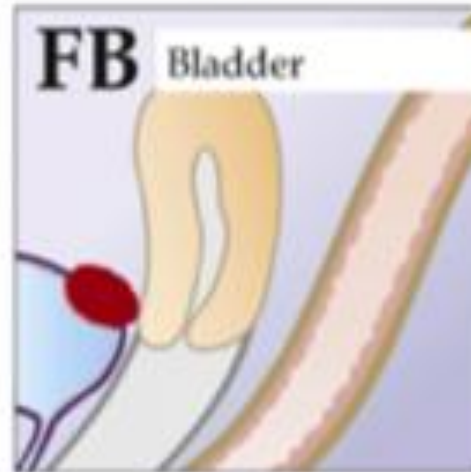
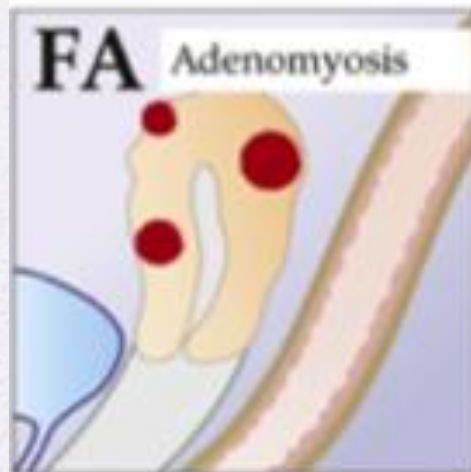


2
1 - 3 cm



3
> 3 cm





© Kecks

PLAN

- I. INTRODUCTION
- II. CLASSIFICATION
- III. EPIDEMIOLOGIE
- IV. PHYSIOPATHOLOGIE
- V. anatomopathologie
- VI. CLINIQUE
- VII. EXAMENS PARACINIQUES
- VIII. STADIFICATION
- IX. PPRISE EN CHARGE
 - Intervenants
 - Buts de la PEC
 - Moyens
 - Stratégie thérapeutique
- I. SURVEILLANCE
- II. PRESERVATION FERTILITE
- III. CONCLUSION

Prise en charge endométriose+ adénomyose

Par qui ?

Buts ?

Moyens?

stratégie ?

PEC par qui ?

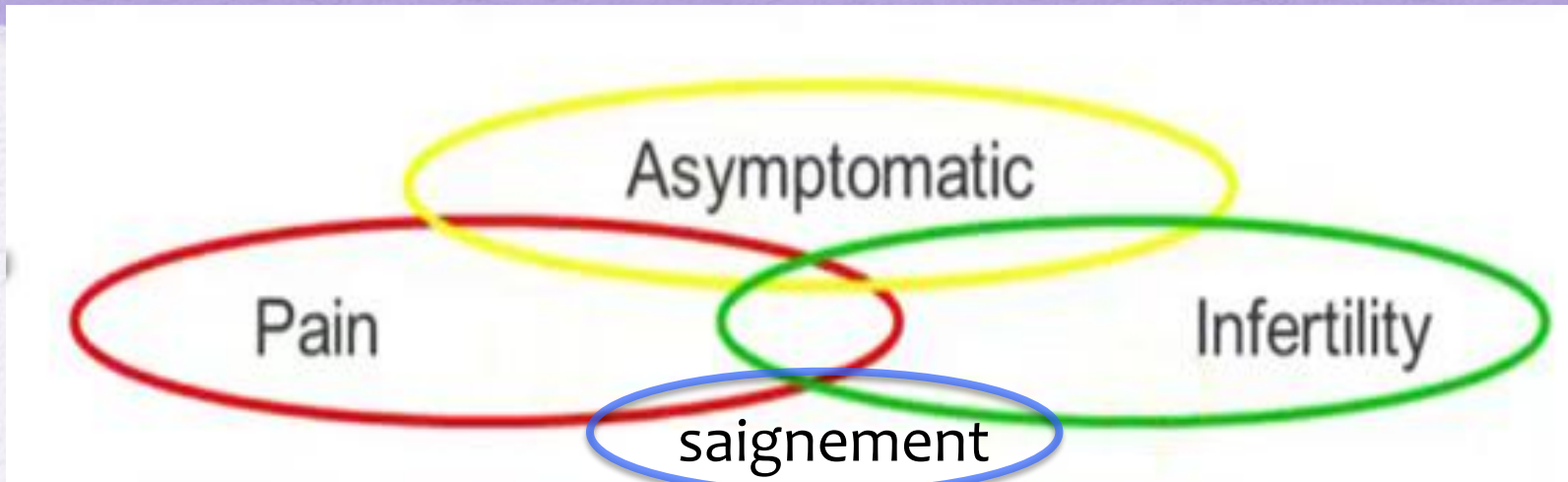
- Gynéco
- PMA^A
- viscéraliste
- Urologue
- Psychologue
- Spécialiste de la douleur

Centre expert



RCP

Buts de la PEC



- soulager les algies chroniques
- Saignements
- optimiser la fertilité.
- Prévenir les récives
- —————> PATIENTE puisse vivre de façon satisfaisante avec sa maladie

Moyens de la PEC



TTT médical

Chirurgie

procréation

médicalement assistée

Douleur

saignement

infertilité



Traitement médical

- il n'existe aucun TTT médical qui fait disparaître la maladie !!!
- Antidouleur
- TTT hormonal

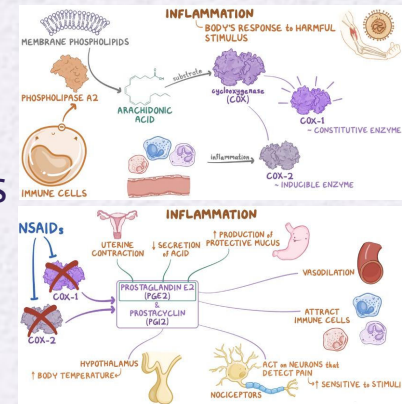
Traitement médical

TTT médical antidouleur

- Les AINS : efficacité similaire:

algies cycliques, non cycliques, dysménorrhée

- l'inhibition de la cyclo-oxygénase** (à l'origine de la synthèse des prostaglandines).
- Ibuprofène 200/400 mg ,
- ac méfénamique 1CPx3/j+++**
- première intention : si **dysménorrhée modérées isolées**.
- dès le début des règles** (Ou 2à 3j avant si pas assez efficace)
- pendant 48 à 72 heures.



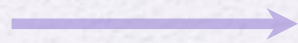
Traitement médical

TTT médical
antidouleur

Douleur d'origine neuropathique :

- **consultations antidouleur** . (Neurontin , Laroxyl , Lyrica) .
- **approches corporelles antidouleur**(ostéopathie, acupuncture,yoga,..)

approches corticales(méditation, sophrologie..)



Efficaces à titre individuel

- douleurs chroniques : évaluation interdisciplinaire :

gynécologues, **algologues**, sexologues, psychologues et assistantes sociales

Traitement médical

TTT médical
hormonal

- **Contraception oestro-progestative combinée**
 - **Progestatifs**
 - -Macroprogestatifs
 - Danazol
 - Diénogest
 - DIU Levonorgestrel
 - **GnRHa (analogues de GnRH)**
 - **Antagonistes GnRH**
 - **Inhibiteurs de l'aromatase**
- Nouvellement indiqués dans l'endométriose



Contraception orale combinée (COC)

- ↓ Dlr
- Les COC inhibent la production d'œstrogènes ovariens.
- **monophasiques de deuxième génération** contenant de 15 à 30 G d'éthinylestradiol
- Prise Cyclique ou **continue** (Attention cp placebo)
- Si **métrorragies** > **prise continue** de xxx mois : fenêtre de 7 j
- Risque thromboembolique, age, risque cardiovasculaire
....



Siu levonorgestrel 52mg

- une atrophie de l'endometre (par décidualisation)
- *Indication* : dysménorrhée, douleurs pelviennes cycliques, ménorragies, dyspareunies++
- entraîne : Aménorrhée chez 60% des patientes , une réduction marquée du volume utérin de 10 à 23 % après un an
- attention si hypertrophie utérine importante : risque d'expulsion +++
- Possibilité de GnRH-a pendant quelques mois avant si : utérus de grande taille
- effets secondaires : dépression, l'acné, les maux de tête, la prise de poids, la sensibilité mammaire et les kystes ovariens (attention si syndrome premenstruel)

diénogest

- Progestatif hybride (19 nortestosterone, 19 norprogesterone)
- environnement hyp-ooestrogénique , hyperprogésteronique
- aussi efficace que GnRHa (scores de douleurs et la qualité de vie) .
- Résultat apparaît entre 3_6mois
- persistance de la réduction des scores de douleurs pelviennes à 12 mois après l'arrêt du traitement
- 1cp 2mg/J en continu
- Métrorragie+ céphalées
- Effet contraceptif pas sur :attention si pas de désir de grossesse ajouter une méthode barrière

macroprogestatifs

- (AMM: *acétate de chlormadinone,, médrogestone*)
(*acétate de nomégestrol, acétate de cyprotérone*)
- effet antigonadotrope puissant
- Très prescrit OR études anciennes
- Efficaces en schéma continu
- Risque de méningiome : Suivi /IRM
- effets secondaires : prise de poids (7 à 10 % des patientes), cutanés (acné, sécheresse), saignements, perte des cheveux, diminution de la libido.

DMPA

- =Progestatif retard (dérive: 17 hydroxypne)
- antigonadotrope
- Efficace dans 80 à 90 % des cas (dysménorrhées, dyspareunies, douleurs pelviennes chroniques)
- maintien des effets à 6 mois de la fin des traitements
- Utilisation limitée: car effets secondaires ++
 - Meme Effets Ilaires macroprogestatifs
 - Effets androgéniques
 - délai de reprise de l'ovulation prolongé
- l'utilisation a long terme : altération DMO possible

- Dérivé de l'éthinyl-testostérone
- action **antigonadotrope** puissante (inhibe la synthèse des gonadotrophines)+++
- **Efficace**
- Aménorrhée après 6 semaines de traitement
- **MAIS effets secondaires** acné et peau grasse, prise de poids, atrophie mammaire
- raucité de la voix myalgies,. métrorragies bouffées de chaleur
- Peu utilisé

GnRHa

- Ménopause chimique
- Diminue dlr de 3_6points en 10 mois (EVA)
- diminue la taille lésions et de l'utérus
- efficace: ménorragies
- Triptoréline 3mg/28 jours ou 11.25 mg/3 mois
- Durée pas au delà de 12 mois (pas d'études)
- Add back thérapie 1 mg de 17b-estradiol add back TTT (perte osseuse+ signe d'hypoestrogénie)
- CI adolescente

Nouveaux traitement :

- Antagonistes GnRH
- Inhibiteurs de l'aromatase

Interventions non chirurgicales

Pour l'adénomyse:

- [themoestruction](#)
 - semble Meilleure que l'endométrectomie
 - Agit sur les lésions profondes
- [HIFU](#) : nouvelle technique , pas de recul à long terme ; CI si désire de fertilité
- [Embolisation des artères utérine](#) : amélioration 70% à 5 ans mais CI si désire de grossesse

CHIRURGIE

- Groupe hétérogène  techniques multiples
- Doit être faite par un expert pour éviter les chirurgies itératives ++++
- Doit toujours être suivi de TTT médical en post opératoire en absence de désir de grossesse Si traitement conservateur



diminution du risque de récurrence

Chirurgie a-adénomyose

1/Chirurgie conservatrice si adénomyose focale

- Endométrectomie hysteroscopique
- Adenomyomectomie

1/Chirurgie radicale: hysterectomie totale

Chirurgie. b- Endométriose externe

1/Traitement conservateur

Coeliochirurgie

- destruction des lésions superficielles / coagulation bipolaire ou laser CO₂
- Resection des noyaux d'endométriose profonde
- Chirurgie difficile : Pas de plan de clivage avec les tissus avoisinants : gynéco expert en endométriose
- Respect des plexus nerveux : nerve-sparing : prévient les sequelles urologiques post-op (retention urine)
- +- Autres gestes / RESECTION ANASTOMOSE DIGESTIVES , urétérale
- But: rétablir les conditions anatomiques les plus proches possibles de la normale et les plus favorables la fécondation
- TTT médical postop en absence de désir de grossesse++++++

2/Traitement radical

- hystérectomie totale + annexectomie bilatérales+ enlever le maximum des lésions
- La castration supprime les hormones ovariennes et entraîne la régression des lésions restantes.

Chirurgie.c- endométriose

- COELIOSCOPIE
- Kystectomie : attention chez la femme jeune et ou infertile : baisse de la réserve ovarienne+++
- Vaporisation au laser

Stratégie de PEC

Ttt médical/ chirurgie / PMA





Recommandations CNGOF, HAS



RCP

++++

Indications thérapeutiques

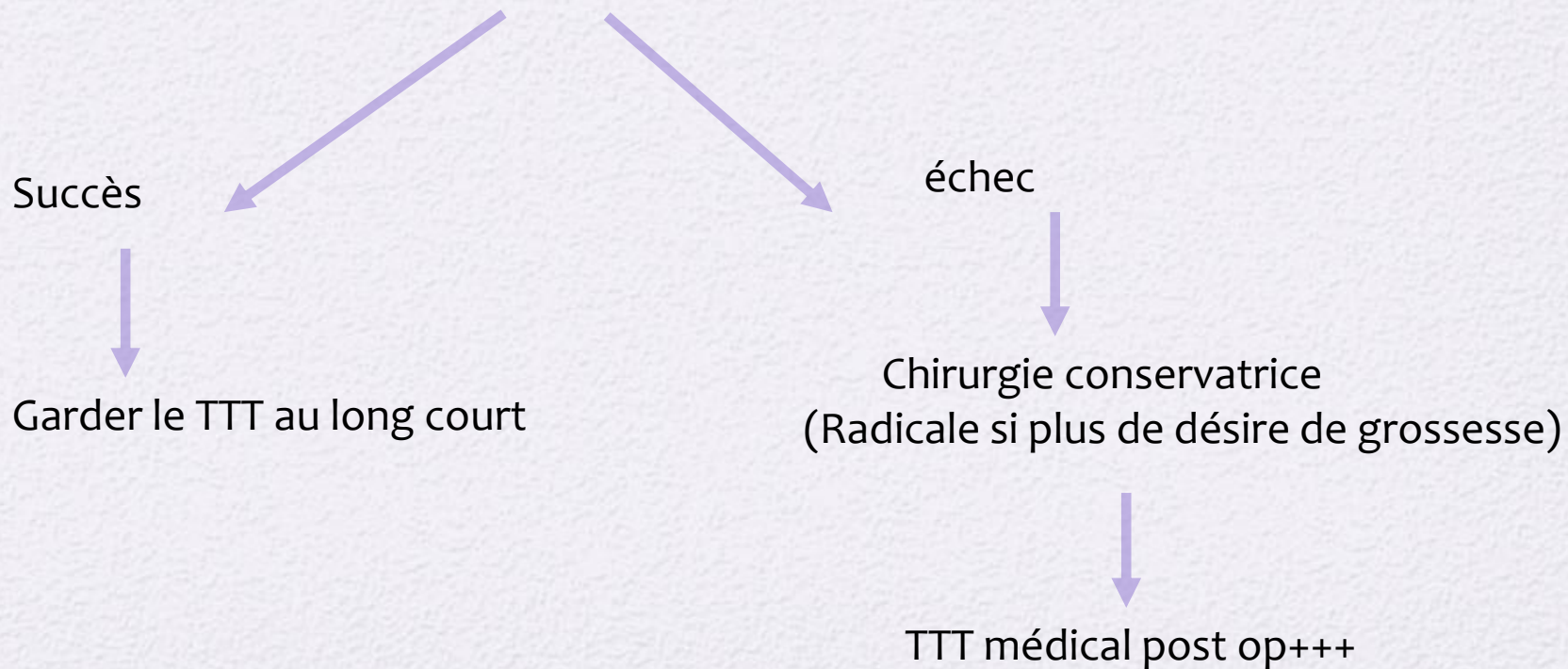
- 1-Douleur sans infertilité ni désir immédiat de la grossesse
- 2- Désire de la grossesse

1- Douleur

QE!!

Sans infertilité ni désir immédiat de grossesse

1 ère ligne: diénogest ,Contraception o-p, progestatifs,
2^{ème} ligne: agoniste GNRH



2-Désire de grossesse

QE!!

- Chirurgie: - améliore fertilité surtout dans l'année suivante
 - baisse de Reserve ovarienne si endométriose
 - complications!
 - adénomyose : chirurgie difficile



indiquée si endométriose légère et si on pense que la fertilité peut être rétablit par chirurgie seule sans PMA



Chirurgie: au bon moment et une fois dans la vie+++++

Préservation de fertilité

+++

→ Avant chirurgie +++

- Si chirurgie itérative
- Si endométriose bilatéraux, endométriose récidivant
- si endométriose >5 cm

Dépistage , information, soutien

Paramètres d'entrée

Age :

18 21 24 27 30 33 36 39 42 45

Au cours des derniers mois, avez-vous souffert de façon régulière de :

Douleurs pelviennes spontanées :

Douleurs fortes, violentes, localisées dans le bas du ventre, pendant les règles :

Non

Douleurs fortes, violentes, localisées dans le bas du ventre, en dehors des règles :

Non

Les douleurs sont d'une violence, envahissante :

Non

Au fur et à mesure des semaines, les douleurs s'intensifient :

Non

Les douleurs surviennent fréquemment et / ou persistent quelque temps :

Non

Statut/Sortie

[1] "Calcul terminé."

Vous appartenez au :

Groupe à risque faible d'endométriose

Votre probabilité d'avoir une endométriose est de :

1%

Calcul basé sur vos réponses au questionnaire et sur un taux de prévalence hypothétique de 34 % avant le test. Ce calcul ne remplace pas une consultation médicale.

ENDOFRANCE : SOUTIENT, INFORME ET AGIT POUR LES JEUNES !



Autres pays:

Algothmes, applications ...

Prochainement endoMAROC !





conclusion

- Endométriose : **maladie systémique**
- **Role du généraliste +++++. : Diagnostic : clinique++++**
- **Radiologique**
- **réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP)**
- **Approche moderne:** diagnostic clinico-RX traitement médical (l'hormonothérapie + TTT anti DLR)
- **Traitement médical à la carte** : le moins d effets II, le moins cher
- **Chirurgie: au bon moment et une fois dans la vie**
- À ce jour pas de traitement médical **curatif!!!**